“Lyssnar de verkligen?”

Unga vuxnas upplevelser av mötet med socialtjänsten vid psykisk ohälsa



Av: Valentina Alwan & Lilia Hatem

Handledare: Linda Kridahl

Södertörns Högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper

Kandidat/Magisteruppsats 15 hp

Psykisk ohälsa | Vårterminen 2026

Socionomprogrammet

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

Abstract

Mental health problems among young adults have increased in recent years and constitute a significant societal challenge. Social services play an important role in providing support to individuals in vulnerable life situations, yet there is limited research focusing on how young adults themselves experience this contact in Swedish social services. The aim of this study is to explore how young adults with experiences of mental health problems perceived their encounters with Swedish social services, with a particular focus on experiences of treatment, participation, and perceived support. The study is based on a qualitative research design using semi-structured interviews with young adults in Sweden aged 20–27 who have previous experience of contact with social services. The collected data were analyzed using thematic analysis, guided by an interpretative and constructionist approach, enabling an in-depth understanding of participants' subjective experiences. The findings indicate that the quality of the encounter is strongly influenced by relational factors such as being listened to, respected, and taken seriously. Participants highlight the importance of feeling involved in decisions concerning their support, while also describing barriers such as lack of clarity, limited accessibility, and experiences of stigma. Both facilitating and hindering factors were identified in relation to how support is perceived and utilized. The study contributes to increased knowledge about young adults' perspectives on social services and emphasizes the need for more person-centered, accessible, and participatory approaches within social work practices.

Title: "Do They Really Listen?" Young Adults' Experiences of Encounters with Social Services in the Context of Mental Health Issues.

Authors: Valentina Alwan & Lilia Hatem

Keywords: young adults, mental health, social services, experiences, participation, support

Number of words: 16 586

Sammanfattning

Psykisk ohälsa bland unga vuxna har ökat under de senaste åren och utgör en betydande samhällsutmaning. Socialtjänsten spelar en viktig roll i att ge stöd till personer i utsatta livssituationer, men det finns begränsad forskning som har fokus på hur unga vuxna själva upplever kontakten med den svenska socialtjänsten. Syftet med denna studie är att undersöka hur unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa har upplevt sina möten med den svenska socialtjänsten, med särskilt fokus på erfarenheter av bemötande, delaktighet och upplevt stöd. Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer med unga vuxna i Sverige i åldern 20-27 år som har tidigare erfarenhet av kontakt med socialtjänsten. Det insamlade materialet analyserades genom tematisk analys, väglett av ett interpretativt och konstruktionistiskt perspektiv, vilket möjliggjorde en fördjupad förståelse av intervjupersonernas subjektiva erfarenheter. Resultaten visar att kvaliteten på mötet i hög grad påverkas av relationella faktorer såsom att bli lyssnad på, respekterad och tagen på allvar. Intervjupersonerna lyfter fram vikten av att känna sig delaktiga i beslut som rör deras stöd, samtidigt som de beskriver hinder såsom bristande tydlighet, begränsad tillgänglighet och erfarenheter av stigma. Både främjande och hindrande aspekter identifierades i relation till hur stödet upplevs och används. Studien bidrar till ökad kunskap om unga vuxnas perspektiv på socialtjänsten och betonar behovet av mer personcentrerade, tillgängliga och delaktighetsfrämjande arbetssätt inom socialt arbete.

Titel: “Lyssnar de verkligen?” Unga vuxnas erfarenheter av mötet med socialtjänsten i samband med psykisk ohälsa.

Författare: Valentina Alwan & Lilia Hatem

Nyckelord: unga vuxna, psykisk ohälsa, socialtjänst, erfarenheter, delaktighet, stöd

Antal ord: 16 586

Förord

Denna studie har genomförts som ett gemensamt examensarbete inom socionomprogrammet och har varit en lärorik och utvecklande process för oss båda. Arbetet har präglats av ett nära samarbete där vi kontinuerligt har planerat, diskuterat och reflekterat kring studiens olika delar. Vi har gemensamt ansvarat för samtliga moment, från idé och problemformulering till litteratursökning, metodval och skrivande. Under arbetets gång har vi delat upp vissa uppgifter för att effektivisera processen, men vi har alltid granskat och bearbetat materialet tillsammans för att säkerställa en röd tråd och en gemensam förståelse. Arbetsprocessen har varit både utmanande och givande. Att fördjupa sig i unga vuxnas upplevelser av mötet med socialtjänsten vid psykisk ohälsa har väckt många tankar och insikter kring socialt arbete i praktiken. Litteratursökningen har gett oss en bredare förståelse för forskningsfältet, samtidigt som arbetet med metod och analys har utvecklat vår förmåga att tänka kritiskt och reflekterande. Intervjuprocessen har varit särskilt betydelsefull, då den gett oss möjlighet att ta del av personliga berättelser som bidrar till en ökad förståelse för ämnet. Vi vill rikta ett stort tack till de personer som har deltagit i studien och generöst delat med sig av sina erfarenheter. Vi vill även tacka vår handledare Linda Kridahl för värdefull vägledning och konstruktiv återkoppling under arbetets gång.

Stockholm, 27 april 2026

Innehållsförteckning

Abstract....2

Sammanfattning....3

Förord....4

1. Inledning....7

1.1 Syfte och frågeställningar....9

1.2 Avgränsningar....10

1.3 Disposition....10

2. Tidigare forskning....12

2.1 Sökvägar och sökord för litteratursökning....12

2.2 Redogörelse för relevanta studier....13

2.2.1 Socialt arbete i psykiatrisk kontext: professionell identitet, systemteori och rättighetsbaserade perspektiv i arbetet med unga med psykisk ohälsa....13

2.2.2 Hjälpsökande vid psykisk ohälsa: tillgänglighet, hinder och navigering i komplexa stödstrukturer....14

2.2.3 Relationer och tillgänglighet i psykosocialt stöd till unga med komplexa behov: betydelsen av tillit, flexibilitet och samordnade insatser....16

2.2.4 Kontinuitet och samordning i stöd till unga vuxna: vårdövergångar, delaktighet och relationsbaserat arbete....18

2.2.5 Stigma, identitet och social inkludering i mötet med psykiatrisk vård: unga vuxnas upplevelser av hinder och tillhörighet....17

2.3 Presentation av forskningslucka....21

3. Teoretiska perspektiv....23

3.1 Studiens teoretiska utgångspunkter....23

3.2 Empowerment....23

3.3 Stigma....25

3.4 Teoretisk diskussion....26

4. Metod....29

4.1 Materialinsamling och urval....29
4.2 Bearbetning och analys av materialet....31
4.3 Metodologiska reflektioner....32
4.4 Förförståelse....33
4.5 Etiska reflektioner....34
4.6 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet....35
5. Resultat och analys....36
6. Diskussion....48
6.1 Förslag till framtida forskning....49
6.2 Kritiskt resonemang om studiens resultat....49
6.3 “Implikationer för socialt arbete....50
7. Referenslista....52
8. Bilagor....55
8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide....55
8.2 Bilaga 2 – Informations- och samtyckesblankett....59
8.3 Kodschema....63

1. Inledning

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland unga vuxna i Sverige där både unga män och kvinnor rapporterar höga nivåer av stress, ångest och depression (Jämställdmyndigheten 2020, s. 7, 41). Psykisk ohälsa handlar om olika typer av psykiska besvär eller diagnoser som på olika sätt har en påverkan på hur vi mår och klarar vardagen. Den kan ge lidande för den som drabbas och påverka både sociala relationer och livet i samhället i stort. Psykisk ohälsa står i kontrast till psykiskt välbefinnande, som handlar om att må bra och kunna hantera livets utmaningar (Kunskapsguiden 2024). Statistik visar att mellan år 2013 och 2023 har andelen unga vuxna som får vård för psykisk ohälsa ökat tydligt. För kvinnor steg andelen från ungefär 11 000-12 000 per 100 000 år 2013 till cirka 20 000- 22 000 år 2023. För män ökade andelen från omkring 8000 år 2013 till ungefär 11 000- 12 000 år 2023 (Socialstyrelsen 2024, s. 10).

En långvarig psykisk ohälsa kan leda till utdraget sjukdomsförlopp med långsiktiga konsekvenser, exempelvis påverkan på framtida försörjning och etablering på arbetsmarknaden. Dessutom finns det risker för självskada, psykiatrisk tvångsvård och suicid (Socialstyrelsen 2024, s. 6, 19). Psykisk ohälsa i ungdomsåren lägger grunden för psykisk sjukdom senare i livet, där stress och ohälsa under dessa år är kopplade till långsiktiga effekter och påverkar studielivet samt framtida arbetsliv negativt (Jämställdmyndigheten 2020, s. 9, 45).

Samhället ser ofta psykisk ohälsa som en individuell svaghet snarare än ett strukturellt problem. Samhällsfaktorer såsom normer, maktstrukturer och ekonomiska ojämlikheter bidrar till psykisk ohälsa, men uppmärksammas inte tillräckligt i samhällsdebatten. Det behövs därmed en bredare förståelse där psykisk ohälsa inte endast ses som individens ansvar (Jämställdmyndigheten 2020, s. 7, 20). Det är dessutom inte enbart en medicinsk fråga, utan också en samhällelig utmaning. Detta kräver insatser både från hälso- och sjukvården och på samhällsnivå för att adressera de underliggande orsakerna och förutsättningarna (Socialstyrelsen 2024, s. 5-6, 20).

Socialtjänstens roll i att stödja unga med psykisk ohälsa är viktig. De är en betydande aktör i samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa, särskilt i relation till unga i utsatta

livssituationer. Jämställdmyndigheten framhåller att psykisk ohälsa påverkas av flera avgörande faktorer, där socialtjänsten kan vara en del i stöd och insatser. Socialtjänsten har även ett ansvar att nå unga med behov på ett likvärdigt sätt, eftersom ojämlikhet i vårdkonsumtion kan förekomma (Jämställdmyndigheten 2020, s. 20). För att kunna nå unga som mår psykiskt dåligt, kräver det att socialtjänsten samverkar mellan hälso- och sjukvård och andra samhällsinstanser, för att ge adekvat stöd och behandling (Socialstyrelsen 2024, s. 6, 20). Därmed utgör mötet med socialtjänsten en komplex situation, där individens behov ställs i relation till organisationens ramar och bedömningar. För unga vuxna som varit eller befinner sig i en utsatt situation kan detta påverka hur mötet upplevs, särskilt i relation till känslor av beroende, maktlöshet eller behov av att bli förstådd.

I Sverige regleras socialtjänstens arbete främst genom socialtjänstlagen. Enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska socialtjänsten främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att ge stöd till individer som befinner sig i utsatta livssituationer (Socialstyrelsen, u.å.) vilket inkluderar personer som upplever psykisk ohälsa. Stödet kan exempelvis bestå av ekonomiskt bistånd, boendestöd eller andra sociala resurser, där man har som mål att ge individen möjlighet till ett självständigt liv (Socialstyrelsen, u.å.). För unga vuxna med psykisk ohälsa kan kontakten med socialtjänsten vara en betydande del i att hantera en svår livssituation.

Även om tidigare forskning visar att socialt arbete har en central roll i stödet till unga med psykisk ohälsa, särskilt genom holistiska och systemteoretiska perspektiv samt betoning på relationer och samordning av insatser (Bark et al., 2023, s. 1–2; Gebert & Lowe, 2025, s. 395–396; Munford & Sanders, 2015, s. 423), har vi, såvitt vi kunnat se, funnit få eller inga studier som specifikt belyser unga vuxnas egna erfarenheter av kontakt med den svenska socialtjänsten i samband med psykisk ohälsa. Samtidigt har forskningen i stor utsträckning fokuserat på professionellas perspektiv, organisatoriska förutsättningar och hur välfärdssystemet är uppbyggt och fungerar, exempelvis genom analyser av socialarbetares roll, identitet och arbetssätt (Bark et al., 2023, s. 3, 13; Gebert & Lowe, 2025, s. 404–405). Vissa studier belyser dock ungas erfarenheter av vård och stödsystem generellt (Westberg et al., 2020, s. 4; Johansen et al., 2024, s. 1), men det är inte i relation till socialtjänsten. Detta kan förstås mot bakgrund av att psykisk ohälsa traditionellt främst har betraktats som ett ansvar för hälso- och sjukvården snarare än socialtjänsten (Hagsgård et al., 2025, s. 75). Sammantaget pekar detta på en tydlig forskningslucka, där ungas röster och subjektiva erfarenheter i mötet med den svenska socialtjänsten i mindre grad har uppmärksammats.

Den här studien utgår från ett interpretativt perspektiv med en konstruktionistisk ansats. Det innebär att fokus ligger på att förstå hur människor upplever och tolkar sin verklighet, snarare än att förklara den genom generella lagar eller mätbar fakta (Bryman 2018, s. 45–46). Inom interpretivismen betonas att individers erfarenheter och handlingar behöver förstås utifrån deras egna perspektiv och sammanhang, där forskningens uppgift blir att tolka dessa subjektiva erfarenheter (Bryman 2018, s. 46). Den konstruktionistiska utgångspunkten innebär samtidigt att sociala fenomen ses som något som skapas och förändras i samspelet mellan människor, snarare än som något fast och objektivt (Bryman 2018, s. 51). Exempelvis förstås mötet med socialtjänsten som något vars betydelse formas i relationen mellan individ och socialtjänst. Konstruktionismen betonar även att begrepp och kategorier är socialt skapade och kan förändras över tid och mellan olika sammanhang (Bryman 2018, s. 52). Dessa perspektiv är relevanta för studiens syfte att undersöka hur unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa upplever mötet med socialtjänsten. Perspektiven möjliggör en förståelse för hur intervjupersonerna tolkar sina erfarenheter och hur dessa formas i sociala sammanhang.

Mot denna bakgrund är målet med denna studie att undersöka hur unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa upplevt sina möten med socialtjänsten. Genom att lyfta fram deras egna berättelser och erfarenheter är ambitionen att bidra med kunskap om hur bemötande, delaktighet och stödet upplevs, samt vilka aspekter som kan påverka relationen mellan individ och myndighet.

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa upplever mötet med socialtjänsten, med särskilt fokus på bemötande, delaktighet och upplevt stöd. Studien avser att belysa hur dessa upplevelser formas i samband med socialtjänstens handläggningsprocesser och insatser.

1. Hur beskriver unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa sitt bemötande i kontakten med socialtjänsten?

2. Hur upplever unga vuxna sin delaktighet i beslut som rör deras stödinsatser?

3. Hur uppfattar unga vuxna det stöd de erbjudits av socialtjänsten i relation till sina behov?

4. Vilka aspekter upplever unga vuxna som underlättande respektive hindrande i mötet med socialtjänsten?

1.2 Avgränsningar

Denna studie fokuserar på unga vuxnas upplevelser av mötet med socialtjänsten i samband med psykisk ohälsa. Studien avgränsas till personer i åldern 20-27 år som har erfarenhet av kontakt med socialtjänsten. För att avgränsa det ytterligare ville vi intervjua personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa men som idag mår bättre och inte längre har aktiv kontakt med socialtjänsten. Vi söker alltså inte personer som befinner sig i en akut situation, eftersom det kan göra intervjun känslig och riskera att belasta deras psykiska ohälsa ytterligare. Genom denna avgränsning riktas fokus mot en specifik grupp där psykisk ohälsa visat sig starkt i övergången mellan ungdom och vuxenliv, där behovet av stöd kan vara särskilt framträdande.

Vidare avgränsas studien till att undersöka unga vuxnas egna upplevelser av bemötande, delaktighet och upplevelse av stöd i mötet med socialtjänsten. Studien har inte ett övergripande maktteoretiskt perspektiv, eftersom det ofta kan lägga tonvikten på struktur, hierarkier och institutionell kontroll, vilket riskerar att överskugga individens egna erfarenheter och känslor. Studien behandlar därmed inte socialsekreterares perspektiv eller organisatoriska aspekter inom socialtjänsten i någon större utsträckning. Dock berörs maktaspekter ändå genom empowerment, delaktighet och socialtjänstens myndighetsutövande roll. Maktaspekterna används för att förstå intervjupersonernas upplevelser av delaktighet, kontroll och handlingsutrymme, och är alltså inte avsedda att fungera som en begreppsapparat för en mer övergripande maktanalys av socialtjänsten.

Studien baseras på sex kvalitativa intervjuer, vilket betyder att resultaten inte syftar till att generaliseras till alla unga vuxna med psykisk ohälsa. Syftet är istället att skapa en fördjupad förståelse för hur mötet med socialtjänsten kan upplevas av unga vuxna.

1.3 Disposition

Uppsatsen är uppdelad i flera kapitel. Efter det första kapitlet, som är inledningen, presenteras i kapitel två tidigare forskning som är relevanta för studiens ämnesområde. Här redogörs för forskning om unga vuxnas erfarenheter av psykisk ohälsa och stöd, betydelsen av bemötande och relationer i stödinsatser, hinder för att söka hjälp, social inkludering och identitet samt stärkande av individens självkänsla.

I kapitel tre presenteras studiens teoretiska perspektiv. Här presenteras de teorier och begrepp som används för att analysera det empiriska materialet, såsom *empowerment* och *stigma*. Kapitlet avslutas sedan med en teoretisk diskussion.

Kapitel fyra behandlar studiens metodologiska utgångspunkter. Här beskrivs val av metod, urval, materialinsamling, tillvägagångssätt, bearbetning och analys av materialet, förförståelse, etiska överväganden, samt en avslutande del om våra reflektioner kring metodvalet.

Kapitel fem redovisar studiens resultat tillsammans med en analys av intervjumaterialet. Resultatet presenteras tematiskt utifrån studiens forskningsfrågor.

Kapitel sex är det avslutande kapitlet som innehåller en sammanfattande diskussion där studiens resultat knyts till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Här resonerar vi även kritiskt kring resultatet, samt förslag till framtida forskning.

2. Tidigare forskning

Den tidigare forskningen visar att unga vuxna med psykisk ohälsa många gånger möter ett komplext och svårnavigerat stödsystem, där både strukturella och relationella faktorer påverkar deras möjligheter att få hjälp. Detta är centralt i vår studie, som fokuserar på mötet med socialtjänsten, som är en del av detta system. Majoriteten av den tidigare forskningen fokuserar på vårdinsatser. Socialtjänsten är inte en vårdinsats, men deras arbete ligger nära vårdens arbete med människor som lider av psykisk ohälsa. Dessa studier har därför inkluderats eftersom de bedöms vara relevanta för att förstå socialtjänstens arbete och bemötande av personer med psykisk ohälsa.

2.1 Sökvägar och sökord för litteratursökning

För att identifiera forskning som är relevant för studien om unga vuxnas erfarenheter av att ha kontakt med socialtjänsten vid psykisk ohälsa, genomfördes en systematisk litteratursökning i flera vetenskapliga databaser. De främsta databaserna som användes var PubMed, SocINDEX och Google Scholar, då dessa täcker forskning inom psykologi, socialt arbete och folkhälsa. Sökprocessen kompletterades också med en manuell genomgång av referenser i relevanta artiklar, en metod som kallas “snowballing”, för att upptäcka ytterligare studier.

Sökorden utformades utifrån studiens syfte och centrala begrepp: unga vuxna, psykisk ohälsa och mötet med stödinsatser. Centrala sökord på engelska var: “young adults”, “youth”, “mental health”, “mental illness”, “help-seeking”, “experiences”, “social services”, “social work”, “welfare services”, “support services” samt “transition”. För att fånga olika aspekter av upplevelser och bemötande, inkluderades även ord som “perceptions”, “barriers”, “facilitators” och “stigma”. Sökorden kombinerades med hjälp av boolesiska operatorer såsom AND och OR, exempelvis: “young adults AND mental health AND help-seeking” eller “youth AND experiences AND support services”.

Eftersom forskningen om den svenska socialtjänsten var begränsad breddades sökningarna till att även inkludera närliggande områden, såsom psykiatri, frivilligorganisationer och övergångar mellan olika vårdsystem. Detta möjliggjorde inkludering av studier som belyser liknande processer och upplevelser, exempelvis hinder i hjälpsökande (Westberg et al., 2020), erfarenheter av vårdrelationer (Johansen et al., 2024) samt övergångar mellan barn- och vuxenvård (Broad et al., 2017). Inklusionskriterier var att studierna skulle vara

peer-reviewed, publicerade på engelska, samt fokusera på unga eller unga vuxna med psykisk ohälsa. Kvalitativa studier prioriterades då de ger fördjupad förståelse för individers upplevelser. Exklusionskriterier var studier som enbart fokuserade på medicinsk behandling utan att belysa upplevelser eller social kontext. Sammanfattningsvis präglades litteratursökningen av en bred ansats för att fånga ett komplext forskningsfält där socialtjänstens roll ofta studeras indirekt, vilket motiverar behovet av föreliggande studier.

2.2 Redogörelse för relevanta studier

2.2.1 Socialt arbete i psykiatrisk kontext: professionell identitet, systemteori och rättighetsbaserade perspektiv i arbetet med unga med psykisk ohälsa

En studie av Bark, Dixon och Laing (2023) är en systematisk scoping review som undersöker socialarbetares professionella identitet inom psykiatriska och mentalvårdstjänster globalt. Forskningen visar att socialarbetare i mentalvården bidrar med unika, holistiska och sociala perspektiv som betonar sociala determinanters roll och rättigheter för serviceanvändare (Bark et al,. 2023, s. 1-2). Trots detta möter de betydande organisatoriska och interprofessionella utmaningar, där den biomedicinska inriktningen ofta dominerar och marginaliserar sociala tillvägagångssätt. Detta kan leda till att socialarbetares roll och identitet försvagas i teamen, vilket påverkar deras möjligheter att främja sociala modeller för återhämtning och rights-based tillvägagångssätt, i linje med internationella riktlinjer från FN och WHO (Bark et al,. 2023, s. 3, 13). En viktig slutsats är att socialarbetares professionella kapital, grundat i deras kunskap och värderingar, behöver stärkas för att motverka denna marginalisering och möjliggöra en tydligare tillämpning av deras unika kompetenser inom psykiatrins kontext. Studien understryker att socialt arbete kan spela en avgörande roll i att integrera sociala perspektiv i psykiatrisk vård och därigenom förbättra vårdens kvalitet för personer med psykisk ohälsa (Bark et al,. 2023, s. 1-2, 13).

Studien av Bark et al. (2023) är relevant för unga vuxna med psykisk ohälsa som möter socialtjänsten eftersom den belyser socialarbetares potential att främja sociala och rights-based perspektiv inom psykiatrin. Trots utmaningar som marginalisering och dominerande biomedicinska modeller, kan socialarbetare bidra med holistiska bedömningar och individanpassade insatser som tar hänsyn till sociala faktorer, vilket är avgörande för unga vuxnas återhämtning och inkludering. Studien understryker vikten av att stärka

socialarbetares professionella identitet och resurser för att möjliggöra en mer holistisk och rättighetsbaserad stödform för unga vuxna i behov av psykiatrisk hjälp.

Gebert och Lowe (2025) utforskar och klarlägger socialarbetares unika epistemologiska förståelse av psykisk ohälsa hos ungdomar genom ett systemteoretiskt och trauma-informerat perspektiv. Socialt arbete analyseras utifrån hur det särskiljer sig i sitt angreppssätt på psykisk ohälsa, med fokus på systemteorier såsom Bronfenbrenners ekologiska systemteori, Engel's biopsykosociala modell och Person-in-Environment-perspektivet (PIE) (Gebert & Lowe 2025, s. 395-396, 401). Studien visar att detta systematiska tänkande är centralt för socialarbetares formuleringsarbete, vilket ofta utgörs av en dynamisk hypotesutveckling kring klientens problemformulering, som integrerar biologiska, psykologiska och sociala faktorer, samt en förståelse av trauman och sociala orättvisor (Gebert & Lowe 2025, s. 396, 404-405). Detta är särskilt relevant inom organisationer som arbetar med ungdomar i svåra och komplexa livssituationer, där sociala, kulturella och historiska faktorer samverkar till psykisk ohälsa. Studien understryker att en fördjupad förståelse av hur socialarbetare formar och använder teori i praktik kan bidra till att stärka den professionella identiteten och den evidensbaserade praxisen inom området (Gebert & Lowe 2025,s. 406, 409). Sammanfattningsvis bidrar studien med en viktig teoretisk och empirisk översikt som understryker socialarbetets systemorienterade och miljöfokuserade perspektiv vid bedömning och intervention vid psykisk ohälsa hos unga. Den belyser samtidigt behovet av att integrera trauma-informerade perspektiv i denna teoretiska bas för att bättre kunna möta komplexiteten i ungdomars psykiska ohälsa.

För att unga vuxnas möte med socialtjänsten ska bli mer meningsfullt, behöver alltså socialarbetare enligt Gebert och Lowe (2025) använda ett trauma-informerat och systemteoretiskt perspektiv, som betonar individens relation till omgivande samhälle och miljö. Genom att förstå ungas psykiska ohälsa som ett resultat av komplexa sociala, biologiska och psykologiska faktorer kan socialtjänsten erbjuda helhetsorienterat stöd som tar hänsyn till både individuella erfarenheter och strukturella hinder. Detta ökar möjligheten att bemöta unga vuxnas behov på ett empatiskt och effektivt sätt, och motverkar stigma eller ensidiga medicinska förklaringar som riskerar att marginalisera deras livssituationer.

2.2.2 Hjälpsökande vid psykisk ohälsa: tillgänglighet, hinder och navigering i komplexa stödstrukturer

En studie från Sverige (2020) presenterar unga vuxnas erfarenheter av psykisk ohälsa och deras process att söka och få stöd inom vård- och stödsystemet. Westberg et al. (2020, s. 1-2) utforskar processen för hjälpsökande bland unga med psykisk ohälsa, som trots ökade problem inte alltid får tillgång till stöd. Genom intervjuer med tretton unga personer (15–23 år), framkom "Lost in space" som studiens kärnkategori. Denna kärnkategori speglar både den unges egen upplevelse av sig själv och sin psykiska ohälsa, samt den utmanande processen att söka och erhålla professionellt stöd (Westberg 2020 s. 4). Studien identifierade flera betydande hinder för hjälpsökande, såsom bristande kunskap om psykisk ohälsa och befintliga stödtjänster, vilket ofta resulterade i att unga först försökte hantera problemen på egen hand (Westberg 2020 s. 8). "Lost in space" utvecklades vidare i tre faser: att försöka förstå egna upplevelser och hantera problem (Drifting), att söka hjälp genom upprepade försök och kontakter (Navigating), och att finna stöd som känns rätt (Docking)(Westberg 2020, s. 4). Studiens slutsats var att unga med psykisk ohälsa möter ett fragmenterat stödsystem. Författarna betonar behovet av att samhället tillhandahåller heltäckande, ungdomsvänliga och flexibla stödtjänster, så att inget ungdomsförsök att söka hjälp går förlorat (Westberg 2020, s. 9). Diskussionen runt detta belyser hur "Lost in space" väl fångar den ensamhet och osäkerhet unga kan känna när de navigerar i en ofta svårtillgänglig vårdapparat (Westberg 2020, s. 6), och understryker vikten av ett mer samordnat och lyhört vårdsystem (Westberg 2020, s.8-9).

I likhet med den föregående studien belyser Hulin et al. (2024) vikten av kontinuitet, individanpassning och tillgänglighet i stödinsatser, men denna studie lyfter snarare fram komplexiteten i att navigera mellan olika aktörer och betydelsen av alternativa stödformer såsom kamratstöd. Hulin et al. (2024) undersöker vuxnas upplevelser av att söka och få stöd för självskadebeteende från frivilliga, samhällsbaserade och sociala företag (VCSE) i Storbritannien. Genom intervjuer med 23 deltagare identifierade studien både hinder och faktorer som underlättade tillgången till stöd. Studiens huvudsakliga fynd pekar på att brister i serviceflexibilitet och en känsla av att individuella behov inte uppmärksammas ofta minskar sannolikheten för engagemang, både i offentliga och VCSE-organisationer. Deltagare upplevde vårdvägarna som komplexa och svåra att navigera, vilket försvårade tillgången till adekvat stöd. Dessutom framkom en bristande medvetenhet om vilka stödalternativ som fanns tillgängliga (Hulin et al., 2024, s. 1). Långa väntetider och avsaknad av personcentrerad vård lyfts också fram som betydande hinder (Hulin et al., 2024, s. 4). Å andra sidan beskrev

deltagarna hur deras engagemang förbättrades av tjänster som skapade en känsla av gemenskap och tillhörighet. Särskilt kamratstöd, där individer med liknande erfarenheter kunde stötta varandra, spelade en avgörande roll för att etablera denna känsla. Även om online-gemenskaper kunde främja tillhörighet, fanns det också en medvetenhet om risken för att sådant innehåll kunde trigga självskadebeteende (Hulin et al. 2024, s. 5).

Westberg et al. (2020) belyser ungas upplevelser som “lost in space”, vilket illustrerar en känsla att sakna riktning och stöd i kontakten med olika aktörer. Forskningen som handlar om vägar till stöd, pekar på att processen för att söka hjälp ofta präglas av osäkerhet, bristande kunskap och ett fragmenterat system.Denna upplevelse kan stärkas av de hinder som Hulin et al. (2024) beskriver, som bristande tillgänglighet, långa väntetider och svårigheter att förstå hur olika stödinsatser hänger ihop. När det kommer till socialtjänsten kan detta tolkas som att unga vuxna har risken att möta en verksamhet som inte upplevs tydlig och enkel att få grepp om, vilket kan riskera att de inte vill söka hjälp eller fullfölja kontakt.

2.2.3 Relationer och tillgänglighet i psykosocialt stöd till unga med komplexa behov: betydelsen av tillit, flexibilitet och samordnade insatser

Johansen et al. (2024) presenterar unga personers erfarenheter av vårdinsatser vid svåra psykiska problem, med särskilt fokus på relationer till vårdpersonal och hur stödets utformning påverkar deras upplevelser. Studien undersökte upplevelserna hos 14 unga personer (15–19 år) med svåra psykiska problem och komplexa behov som fick vård via Youth Flexible Assertive Community Treatment (Youth Flexible ACT). Genom intervjuer identifierades två huvudteman: "tillitsfulla och samarbetande relationer" och "organisationsfrågor". Ungdomarna värderade starka personliga, "vänskapliga" relationer med personalen, som de upplevde skiljde sig från mer formella möten inom tidigare vård. De betonade vikten av att bli lyssnade på, att personalen fokuserade på lösningar, intressen och resurser, snarare än enbart problem, samt att de inte blev uppgivna om (Johansen et al., 2024, s. 1). Ett viktigt fynd var att deltagarna ofta "testade" personalens tillförlitlighet över tid innan de delade djupare svårigheter, vilket understryker behovet av långvarig och tålmodig relationsbyggande (Johansen et al., 2024, s. 8). När det gäller "organisationsfrågor" framhöll ungdomarna flexibiliteten och tillgängligheten hos Youth Flexible ACT-teamen (Johansen et al., 2024, s. 1). De uppskattade att teamet erbjöd hjälp inom flera livsområden, involverade familjen på ett systematiskt sätt (med respekt för ungdomens gränser) och möjliggjorde möten i olika miljöer som hemmet eller skolan, snarare än bara på en mottagning (Johansen

et al. 2024, s. 6). Kontinuerlig uppföljning under fluktuerande mående var också en trygghetsfaktor (Johansen et al., 2024, s. 9). Studien visar tydligt att det inte bara är *vad* vården erbjuder, utan även *hur* den erbjuds, som är avgörande för unga med svåra psykiska problem. Resultaten indikerar att en vård som är utvecklingsmässigt känslig, respekterar autonomi och erbjuder integrerat och mångfacetterat stöd är central för att möta denna sårbara grupps komplexa behov (Johansen et al. 2024, s. 8).

Johansen et al. (2024) beskriver betydelsen av tillitsfulla och långsiktiga relationer, där unga känner att någon lyssnar och ser dem, utan att deras problem blir deras identitet. Detta blir väldigt relevant för socialtjänsten, där mötet präglas av myndighetsutövning och där makt kan vara tydlig. Forskningen antyder alltså att ett gott bemötande inte enbart handlar om att erbjuda rätt insats. Det handlar om hur relationen formas och upprätthålls över tid.

Munford och Sanders (2015) presenterar resultat från en studie i Nya Zeeland som undersöker erfarenheter hos ungdomar (13-17 år) som använder flera samhällsservicenätverk, inklusive mentalvård, barnskydd, ungdomsbrottsvård och utbildning (Munford & Sanders 2015, s. 415, 417). Studien fokuserar särskilt på de faktorer inom mentalvården som bidrar till effektivt socialt arbete för denna sårbara grupp. Forskarna belyser en djupare förståelse för ungdomarnas livssituation, sociala nätverk, erfarenheter av skadliga miljöer samt deras relation till olika tjänster (Munford & Sanders 2015, s. 417-418). Resultaten visar att framgångsrikt socialt arbete präglas av en ekologisk ansats där individens sammanhang, inklusive familj, samhälle och tjänstesystem, beaktas och integreras i stöd och interventioner. En nyckelkomponent enligt studien, är socialarbetares roll som förespråkare och stödpersoner, vilka hjälper ungdomar att navigera komplexa tjänstesystem, samt att hantera stigma kopplat till psykisk ohälsa. (Munford & Sanders 2015, s. 423, 431). Studien belyser vidare att ett samordnat och kontinuerligt stöd är kritiskt, då fragmenterade och episodiska insatser ofta leder till avbrott i vården med negativa konsekvenser som ökad risk för skolavhopp och kriminalitet (Munford & Sanders 2015, s. 429, 433). Socialarbetare i ungdomscentrerade hälsotjänster har en särskilt viktig funktion att fylla när det gäller att skapa meningsfulla relationer med unga och att främja en positiv identitetskonstruktion trots psykisk ohälsa (Munford & Sanders 2015, s. 432). Sammanfattningsvis framhåller artikeln vikten av att lyssna på ungdomarnas egna erfarenheter och behov, samt att utveckla

samverkande, ekologiska och kontinuerliga interventioner för att förbättra mental hälsa och sociala utfall för unga multipla tjänstanvändare.

Utifrån studien av Munford och Sanders (2015) är det relevant att socialtjänstens arbete med unga vuxna med psykisk ohälsa bör präglas av helhetssyn, uthålliga relationer, aktivt stöd i systemnavigering, family first-ansats och fokus på att motverka stigma. Detta möjliggör att unga kan få meningsfulla insatser som stärker hälsa, identitet och social delaktighet snarare än att fastna i negativa cykler av utanförskap.

2.2.4 Kontinuitet och samordning i stöd till unga vuxna: vårdövergångar, delaktighet och relationsbaserat arbete

Broad et al. (2017) belyser unga vuxnas erfarenheter av övergången mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri, med särskilt fokus på hur denna förändring påverkar deras upplevelse av stöd, delaktighet och kontinuitet i vården vid psykisk ohälsa. Genom en kvalitativ metasyntes, framkom att denna övergång är en turbulent period. Studien identifierade tre centrala teman: det komplexa samspelet mellan flera samtidiga övergångar i livet, balansen mellan autonomi och behovet av stöd, samt faktorer som påverkar ungas övergångsupplevelser (Broad et al. 2017, s. 3-4). Många unga vuxna upplever stora livsförändringar, såsom att flytta hemifrån eller bli förälder, parallellt med vårdomställningen, vilket kan försvåra processen. De uttryckte en önskan om att kunna medverka i planeringen av sin övergång, med individuella vårdplaner som fokuserar på deras mål och behov. Brister i informationsöverföring och att behöva upprepa sin berättelse för nya vårdgivare upplevdes som en stor börda. Studien fokuserar på psykiatrin, samt lägger vikt på individanpassade planer, kontinuitet i vården och en systematik som är lyhörd för samtidiga livsförändringar. Studien understryker behovet av ungdomsengagemang i utformningen av stödtjänster, vilket är avgörande för att bygga broar mellan olika insatser och säkerställa att stödet möter de ungas verkliga behov (Broad et al. 2017, s. 10).

Ämnet om delaktighet och autonomi framhävs tydligt i studier om övergångar i vårdsystemet. Broad et al. (2017) beskriver att unga ofta upplever bristande kontinuitet och begränsat inflytande i samband med övergången mellan barn- och vuxenpsykiatri. Att individen behöver upprepa sin berättelse och anpassa sig till den nya aktören kan skapa negativa känslor. I relation till socialtjänsten kan detta betyda att man behöver arbeta kontinuerligt och samordnat, samt att aktivt inkludera unga i beslut som rör deras livssituation.

En studie från Australien undersöker faktorer som påverkar ungdomars engagemang i Early Psychosis Services (EPS), och lyfter fram socialarbetares roll i att förbättra dessa processer. Genom en fokusgruppsintervju med sex unga vuxna identifierades fem centrala teman som påverkar deras engagemang: erfarenheter av hospitalisering och övergång till samhällsbaserade tjänster, relationen till EPS och dess personal, stigma samt tvångsbehandling, kliniska barriärer inklusive depressiva symtom och substansbruk, samt socialt stöd från familj och vänner. Negative erfarenheter under hospitalisering, särskilt avskrivande och bristande förståelse, ledde till rädsla och ovilja att fortsätta med EPS (Beckwith et al., 2021, s. 105-106). Essentiella faktorer som främjade engagemang var utåtriktade, personcentrerade insatser och ett tillitsfullt förhållande till case managers, inklusive flexibel kontakt och hemmabesök (Beckwith et al., 2021, s. 113-114). Stigma och tvångsbehandling utgjorde barriärer, även om involvering via ett tvångsbeslut ofta motiverades av patienter att initialt delta (Beckwith et al., 2021, s. 114-115). Socialt stöd från familj och vänner visade sig vara avgörande för att upprätthålla engagemang och främja återhämtning (Beckwith et al., 2021, s. 116-117). Studien understryker socialarbetares viktiga roll i att främja ett recovery-orienterat, personcentrerat tillvägagångssätt och att underlätta smidiga övergångar mellan inläggning och samhällsbaserad behandling (Beckwith et al., 2021, s. 118-119). Förbättringar av transitioner och ökad tillgång till stödinsatser rekommenderas för att stärka ungdomars långsiktiga engagemang och återhämtning.

Beckwith et al. (2021) visar att unga vuxna med psykisk ohälsa ofta möter barriärer såsom stigma, osäkerhet och svårigheter att etablera tillit till vårdtjänster. En personcentrerad och recovery-inriktad vårdmodell, som främjar självbestämmande och inkluderar socialt stöd är avgörande för att öka engagemanget. En smidig och informativ övergång mellan inläggningsvård och community-baserad stöd samt användning av outreach och peer-stöd kan förbättra kontinuiteten. Socialtjänsten kan spela en central roll genom att stärka dessa faktorer, arbeta för att minska stigma och skapa förtroendefulla relationer för att främja ungdomars delaktighet i sin egen rehabilitering.

2.2.5 Stigma, identitet och social inkludering i mötet med psykiatrisk vård: unga vuxnas upplevelser av hinder och tillhörighet

En studie från Kanada av Sheikhan et al. (2023) lyfter fram *stigma* och upplevelser av att bli avfärdad som centrala hinder i mötet med vården. Vidare betonar denna studie den interna

psykologiska processen hos unga, såsom osäkerheten kring att vara “sjuk nog”, vilket inte framträder lika tydligt i den tidigare studiens fokus på organisatoriska och praktiska aspekter av stöd. Studien belyser hur *stigma* är ett betydande hinder för ungdomar som söker mentalvårdstjänster, och ger viktiga insikter från deras perspektiv. Forskningen, baserad på virtuella fokusgrupper med unga människor, visar att stigmatiseringens påverkan sträcker sig från det första beslutet att söka hjälp till den löpande upplevelsen inom vårdsystemet. Ett centralt fynd är den ständiga förhandlingen ungdomar ställs inför om de är "sjuka nog" eller "inte sjuka nog" för att få vård (Sheikhan et al., 2023, s. 1). Denna interna kamp återspeglas i vårdgivarnas beslut om att erbjuda stöd, vilket skapar ett gränsland där unga människor kan nekas behandling om de inte passar en stereotyp bild av en mentalvårdspatient (Sheikhan et al., 2023, s. 6). Deltagarna beskrev att de fördröjde kontakten på grund av negativa stereotyper, rädsla för att bli stämplade, och oro för hur sökandet efter hjälp kunde påverka deras professionella identitet eller karriärmöjligheter (Sheikhan et al., 2023, s. 8). När de väl fick tillgång till tjänster upplevde ungdomarna ofta att deras utmaningar antingen biomedicinerades eller trivialiserades av vårdgivare, vilket ledde till känslor av att bli nedlåtande behandlade, avfärdade, eller att deras symptom förminskades (Sheikhan et al., 2023, s. 1). Detta avskräckte dem ytterligare från framtida engagemang (Sheikhan et al., 2023, s. 8).

Nord-Baade et al. (2025) undersöker unga vuxnas upplevelser av identitet och hur dessa påverkar känslan av social inkludering vid psykisk ohälsa. Studien utforskar unga vuxnas (22–29 år) upplevelser av identitet. Studien lyfter fram att, utöver objektiva mått som arbete och bostad, är subjektiva faktorer, särskilt identitet, understuderade men avgörande för social inkludering (Nord-Baade et al., 2025, s. 2). Resultaten presenterades i två huvudteman: "Vilka de är" och "Vilka de vill vara". Under "Vilka de är" framkom att deltagarna länge hade en känsla av att stå utanför, känna sig annorlunda och uppleva sig som värdelösa eller att de inte betyder något. Tema två, "Vilka de vill vara", belyste en önskan att vara någon annan och ett starkt behov av att omdefiniera sig själva (Nord-Baade et al., 2025, s. 1). Många deltagare var medvetna om hur deras negativa självbild utgjorde ett hinder för social inkludering och trots en vilja att förändra detta, uttryckte de tvivel om hur det skulle vara möjligt, särskilt då de upplevde att ämnet sällan diskuterades av vårdgivare (Nord-Baade et al., 2025, s. 7). Studien understryker vikten av att systematiskt arbeta med subjektiva aspekter som identitet för att tackla social exkludering i denna sårbara grupp. Den pekar på att mentalvården och missbruksvården ofta brister i att uppmärksamma sociala faktorer i behandlingen av komplexa problem (Nord-Baade et al., 2025, s. 1-2).

Frågan om stigma och identitet fördjupar förståelsen av de mer subtila hinder som unga möter. Sheikhan et al. (2023) belyser hur unga internaliserar föreställningar om att inte vara "sjuka nog", vilket kan resultera i att de inte längre vill söka hjälp eller känner sig ifrågasatta i mötet med vården. Det kan förstärka känslan att bli avfärdad eller inte tagen på allvar. Nord-Baade et al. (2025) menar vidare att psykisk ohälsa påverkar ungas identitet och känsla av social tillhörighet, där många kan känna att de står utanför och saknar värde. I mötet med socialtjänsten är detta viktigt eftersom bemötandet antingen kan bidra till att förstärka känslan att känna sig utanför eller fungera som en motkraft som ger bekräftelse till individens känsla av värde.

2.3 Presentation av forskningslucka

Även om tidigare forskning tydligt visar att socialt arbete har en central roll i stödet till unga med psykisk ohälsa (Bark et al., 2023, s. 1–2; Gebert & Lowe, 2025, s. 395–396), framträder en begränsad kunskap om hur unga vuxna själva upplever kontakten med socialtjänsten i Sverige. Forskningen har i stor utsträckning fokuserat på professionellas perspektiv, organisatoriska villkor och teoretiska utgångspunkter inom socialt arbete (Bark et al., 2023, s. 3, 13; Gebert & Lowe, 2025, s. 404–405), samt på hur stödsystem fungerar mer generellt.

Trots att vissa studier lyfter ungas erfarenheter av att söka hjälp och navigera i vård- och stödsystem (Westberg et al., 2020, s. 4; Hulin et al., 2024, s. 1), och betydelsen av relationer och bemötande (Johansen et al., 2024, s. 1), riktas dessa inte specifikt mot socialtjänsten i en svensk kontext. Därmed saknas i stor utsträckning forskning som belyser unga vuxnas egna, subjektiva upplevelser av mötet med socialtjänsten. Detta kan förstås mot bakgrund av att psykisk ohälsa historiskt och institutionellt främst har betraktats som ett ansvar för hälso- och sjukvården snarare än socialtjänsten (Hagsgård et al., 2025, s. 75). Socialtjänstens ansvar aktualiseras ofta först när den psykiska ohälsan sammanfaller med social problematik, såsom omsorgsbrister, missbruk, våldsutsatthet, hemlöshet, kriminalitet eller behov av myndighetsutövning. Forskning om unga vuxnas psykiska ohälsa har därför i större utsträckning bedrivits inom vård- och stödkontexter än i relation till socialtjänsten specifikt. Denna gränsdragningsproblematik aktualiseras även i SOU 2025:38, där frågor om ansvarsfördelning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård diskuteras i relation till psykisk ohälsa, risk och destruktiva handlingsmönster. Detta innebär att det finns en tydlig

forskningslucka, där ungas röster behöver synliggöras för att bättre förstå hur stödet kan utformas på ett mer tillgängligt och meningsfullt sätt.

Socialtjänsten har sitt dubbla uppdrag av både stöd och myndighetsutövning. Detta skapar en särskild kontext där maktrelationer, bedömningar och beslut kan påverka hur unga vuxna med psykisk ohälsa upplever kontakten. Denna studie är därför särskilt relevant eftersom den bidrar med en fördjupad förståelse för socialtjänsten som en viktig aktör i unga vuxnas liv.

Mot denna bakgrund finns ett tydligt behov av studier som fokuserar på unga vuxnas subjektiva erfarenheter av socialtjänsten. Genom att ha fokus på bemötande, delaktighet och stöd kan studien bidra med kunskap som är relevant för att utveckla mer ungdomsanpassade, inkluderande och stärkande arbetssätt inom socialt arbete.

3. Teoretiska perspektiv

3.1 Studiens teoretiska utgångspunkter

Denna studie utgår från två centrala teoretiska perspektiv: *empowerment* och *stigma*. Dessa teorier har valts eftersom de tillsammans kan bidra till en fördjupad förståelse av unga vuxnas upplevelser av mötet med socialtjänsten i samband med psykisk ohälsa.

Empowerment används för att analysera i vilken utsträckning unga vuxna upplever att de har möjlighet att påverka sin egen situation och vara delaktiga i beslut som rör deras stödinsatser. *Stigmatiseringsteorin* används för att analysera hur psykisk ohälsa kan påverka hur individer bemöts i sociala sammanhang och i kontakten med olika institutioner. Personer med psykisk ohälsa kan i vissa fall möta negativa stereotyper eller fördomar, vilket kan påverka deras upplevelse av bemötande och deras relation till samhällets stödinsatser.

Genom att kombinera dessa två perspektiv skapas ett teoretiskt ramverk som gör det möjligt att analysera individens upplevelser av stöd såväl som de sociala processer som kan påverka relationen mellan klient och socialtjänst.

3.2 Empowerment

Empowerment är ett betydande perspektiv inom socialt arbete och beskriver en process där individer eller grupper stärker sin förmåga att få mer kontroll över sina egna liv, det som påverkar dem, samt de omständigheter som formar dem. Målet är att personer i maktlösa positioner ska utveckla styrka, kraft och inflytande för att kunna förändra sina livsvillkor och utmana de strukturer som begränsar dem (Askheim 2007, s. 18).

Två viktiga nyckelbegrepp i detta sammanhang är self-determination (självbestämmande) och agency (handlingsförmåga). Self-determination handlar om individens rätt och möjlighet att fatta egna beslut, sätta egna mål och forma sitt liv utifrån egna värderingar, i stället för att enbart anpassa sig till befintliga strukturer. Det handlar om att få kunna vara fri och inte endast behöva följa regler. Det handlar om autonomi och frihet från yttre tvång. Agency syftar på individens förmåga att agera, göra val och påverka sin situation. Det handlar om att vara en aktiv aktör i sitt eget liv i stället för att vara en passiv mottagare. Tillsammans är

dessa två begrepp grunden för ett empowermentperspektiv där den centrala idén handlar om att människan både har rätten att välja och möjligheten att agera (Askheim 2007, s. 26-27).

Askheim och Starrin (2007) fördjupar vidare förståelsen av begreppet *empowerment*. Författarna menar att *empowerment* fungerar både som ett mål och ett medel. Det handlar om att få makt, styrka och inflytande för att bryta känslan av maktlöshet och förändra sina egna livsvillkor. Begreppet har sina rötter i olika sociala rörelser, som medborgarrättsrörelsen, kvinnorörelsen och befrielserörelser, och fick under 1990-talet genomslag som ett centralt perspektiv inom socialt arbete och socialpolitik, ibland beskrivet som ett paradigmskifte (Askheim 2007, s. 18). Samtidigt betonas det att *empowerment* används med varierande och ibland oklara betydelser. Det finns en risk att begreppet förlorar sin ursprungliga innebörd och i stället används som en retorisk term som kan dölja ideologiska skillnader eller till och med fungera som ett verktyg för social kontroll. Begreppet har därför kritiserats för att det ibland reduceras till ett "förgyllt redskap" som inte alltid leder till verklig maktförskjutning (Askheim 2007, s. 19).

Forskning betonar att *empowerment* inte endast handlar om enskilda människors process, utan också en kollektiv och strukturell sådan. Det innebär att vara kritisk medveten kring de maktstrukturer som skapar och upprätthåller ojämlikhet, samt att samla kraft, både individuellt och gemensamt, för att skapa förändring (Askheim 2007, s. 22). Inom litteraturen identifieras olika teoretiska perspektiv på *empowerment,* som empowerment som motmakt, en marknadsorienterad syn, en terapeutisk inriktning och en mer kritisk förståelse som ser det som en styrningsstrategi. Trots att det finns olika tolkningar finns det en gemensam grund i en positiv människosyn. Här ser man individen som aktiv, handlingskraftig och kapabel att själv veta vad som är bäst under rätt förutsättningar (Askheim 2007, s. 29-31).

Samtidigt finns det en viktig punkt som lyfts fram, där *empowerment* ibland ses som ett sätt att ge människor frihet och ansvar för sitt eget liv. Detta kan dock leda till en individualisering av ansvar, där strukturella hinder förbises och där professionella och institutionella ramar inte ifrågasätts i tillräcklig grad. Ur Foucaults maktperspektiv kan man förstå *empowerment* som en form av kontroll, där individen uppmanas att ta ansvar för sitt eget liv, men inom ramarna som definieras av experter och institutioner. Det är då möjligt att självbestämmande blir en del av en styrningslogik (Askheim 2007, s. 50,51).

Sammanfattningsvis är empowerment ett komplext och mångdimensionellt begrepp som inkluderar möjligheter såväl som utmaningar. För att vara meningsfull i praktiken kräver det

en balans mellan individens egenmakt och ett kritiskt förhållningssätt till de strukturer och maktrelationer som påverkar människors liv.

3.3 Stigma

Stigma är ett socialt fenomen som handlar om att en person eller en grupp tilldelas negativa egenskaper. Dessa negativa egenskaper gör att de ses som annorlunda i jämförelse med vad som anses vara normalt i samhället. Detta betyder att personens sociala identitet nedvärderas vilket kan leda till att hen inte fullt blir accepterad eller erkänd av andra människor (Goffman 2012, s. 5). *Stigma* uppstår alltså när en person möter de sociala normer som finns i ett samhälle. Det är inte en egenskap som personen har i sig, utan något som sker i mötet mellan personen och samhället. I teorin kan *stigma* förstås som en process där människor delas in i kategorier utifrån vad som förväntas av dem. När en person avviker från dessa förväntningar uppstår en skillnad mellan hur personen uppfattas (den förväntade identiteten) och hur personen faktiskt är. Denna skillnad kan leda till att personen blir sedd som mindre värd eller annorlunda. Det påverkar både självbild och sociala relationer (Goffman 2012, s. 10-11). *Stigma* kan alltså ses som ett sätt att upprätthålla sociala gränser och normer i samhället.

Centrala begrepp inom stigmateorin förklarar denna process. Den virtuella (skenbara) sociala identiteten handlar om vad vi förväntar oss av en person baserat på hur vi kategoriserar dem, medan den faktiska sociala identiteten beskriver personens verkliga egenskaper (Goffman 2012, s. 10). Skillnaden mellan dessa, som kallas diskrepans, är det som gör att *stigma* uppstår. När människor märker eller ser denna skillnad påverkas personens sociala identitet negativt (Goffman 2012, s. 28, 44). Begreppet social information handlar om vilken information en person själv förmedlar om sig själv, vilket påverkar hur andra uppfattar och tolkar personen. Avvikelse är också viktigt och handlar om beteenden eller egenskaper som bryter mot normer. Även mindre avvikelser kan få stor social betydelse beroende på sammanhanget (Goffman 2012, s. 5).

Forskare inom området menar ofta att *stigma* inte endast beror på individens egenskaper, utan på sociala relationer och maktstrukturer. Det är i samspelet mellan individ och omgivning som *stigma* uppstår och upprätthålls (Goffman 2012, s. 11). Fokus ligger därför på hur människor som upplever *stigma* ser på sin situation, hur de hanterar sin sociala identitet och

hur de reagerar på omgivningens bemötande. Detta inkluderar att "bemästra de sociala spänningarna och kontrollera informationen i sig" (Goffman 2012, s. 146).

Goffman betonar även om de sociala konsekvenserna av *stigma*, där möten mellan stigmatiserade och "normala" personer kan präglas av osäkerhet och obehag. Det kan visa sig genom att man undviker blickar, försöker vara överdrivet glad eller är tvungen att prata (Goffman 2012, s. 27). Han beskriver även hur personer som har blivit stämplade ofta söker sig till andra i liknande situationer eller till personer som är accepterande. Där kan de känna tillhörighet och bekräftelse (Goffman 2012, s. 44). Detta kan även inkludera att de med tiden kan lära sig att hantera sådana situationer och bryta igenom den initiala distansen med "personliga" samtal. Även "normala" personer kan med tiden utveckla en mer överseende attityd (Goffman 2012, s. 60).

Sammanfattningsvis visar Goffmans teori tydligt att *stigma* är något som formas genom sociala processer i relation till normer, förväntningar och interaktioner. Det handlar alltså inte enbart om individens egenskaper, utan hur dessa tolkas och värderas i ett socialt sammanhang. Detta får betydelse för individens identitet, relationer och livsvillkor. Denna process inkluderar också hur individer socialiseras in i sin stigmatiserade situation, oavsett om de föds med den, får den senare i livet, eller upptäcker den om sina föräldrar (Goffman 2012, s. 43). Stigmatiserade individer kan utveckla olika strategier för att hantera information om sitt *stigma,* exempelvis genom att försöka dölja sitt *stigma* eller noggrant planera sina sociala interaktioner. Ibland kan de även vända situationen genom att skämta om situationen för att visa att de inte är rädda för vad andra tycker (Goffman 2012, s. 101, 147).

3.4 Teoretisk diskussion

Valet av *empowerment* och *stigma* som teoretiska utgångspunkter i denna studie hänger ihop med studiens syfte att undersöka hur unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa upplevde mötet med socialtjänsten, särskilt i relation till bemötande, delaktighet och upplevt stöd. Dessa teorier möjliggör en analys som fångar både individens handlingsutrymme samt de sociala processer som kan begränsa detta, vilket är viktigt för att förstå komplexiteten i mötet med socialtjänsten.

Empowerment anses vara relevant eftersom teorin har fokus på individens möjlighet att få kontroll över sitt liv, fatta egna beslut och påverka sin situation. Detta är direkt relevant i relation till studiens frågeställningar om delaktighet och upplevt stöd. Askheim menar i

samband med detta att *empowerment* handlar om att stärka individens förmåga att påverka sina livsvillkor och motverka maktlöshet (Askheim 2007, s. 18). I mötet med socialtjänsten är unga vuxna med psykisk ohälsa ofta i en utsatt situation. De har inte alltid möjlighet att vara delaktiga i beslut om insatser, få stöd och hjälp eftersom besluten i stor utsträckning ligger hos professionella. Genom ett empowermentperspektiv kan vi undersöka i vilken utsträckning dessa unga vuxna upplever self-determination, alltså möjligheten att fatta egna beslut, samt agency, det vill säga deras faktiska handlingsförmåga i processen (Askheim 2007, s. 26-27). *Empowerment* är även särskilt användbar för att undersöka graden av delaktighet i handläggningsprocesser, vilket är en viktig del av studiens operationalisering. Teorin ger också ett analytiskt verktyg för att förstå hur bemötande från socialtjänsten kan främja eller hindra *empowerment.* Ett bemötande som är respektfullt och inkluderande kan till exempel bidra till ökad känsla av kontroll och delaktighet. Om bemötandet dock är mer paternalistiskt kan det förstärka upplevelsen av maktlöshet. Samtidigt gör teorin det möjligt med en kritisk analys av hur ansvar kan individualiseras, där unga vuxna förväntas ta ansvar för sin situation utan att strukturella hinder beaktas (Askheim 2007, s. 50-51). I relation till psykisk ohälsa är detta särskilt relevant eftersom individens handlingsutrymme ofta påverkas av både personliga och strukturella faktorer.

Goffmans teori om *stigma* (1963) kompletterar *empowerment* genom att fokusera på de sociala processer och normer som har påverkan på hur individer blir bemötta och hur de uppfattar sig själva i mötet med socialtjänsten. Utifrån teorin uppstår *stigma* i samspelet mellan individ och samhälle, där vissa egenskaper definieras som avvikande och leder till en nedvärderad social identitet (Goffman 2012, s. 5, 11). För unga vuxna med psykisk ohälsa är detta viktigt eftersom psykisk ohälsa ofta är förknippad med negativa stereotyper och fördomar. Genom teorin om *stigma* kan vi analysera hur bemötande i socialtjänsten formas av sådana föreställningar. Till exempel kan unga vuxna känna att de inte tas på allvar, blir ifrågasatta eller kategoriseras utifrån sin diagnos istället för sina individuella behov. Här blir begreppet diskrepans mellan virtuell och faktisk identitet relevant, eftersom socialtjänsten kan ha andra förväntningar på individen än vad man har om sig själv (Goffman 2012, s. 10-11). Detta kan påverka relationen till handläggare såväl som individens vilja att vara öppen kring sin situation. Stigmateorin hjälper oss vidare att förstå hur unga vuxna hanterar sin sociala identitet i mötet med socialtjänsten. De kan till exempel kontrollera vilken information de delar eller anpassa sitt beteende (Goffman 2012, s. 146). Detta är användbart

för att analysera vilka faktorer som de upplever som hindrande eller underlättande i kontakten. Om de blir bemötta på ett sätt som minskar känslan av *stigma* kan det bidra till ökad tillit och öppenhet, samtidigt som ett stigmatiserande bemötande kan öka risken för distans och motstånd.

Dessa två teorier hänger även nära samman. *Stigma* kan ses som en begränsande faktor för *empowerment*, eftersom negativa föreställningar och sociala normer kan minska individens handlingsutrymme och självbestämmande. Samtidigt kan *empowerment* fungera som ett sätt att motverka *stigma*, genom att stärka individens position och möjligheter att utmana dessa strukturer. Detta betyder att teorierna ihop ger en mer nyanserad förståelse av både hinder och möjligheter i mötet med socialtjänsten. Sammantaget har *empowerment* och *stigma* valts utifrån att de kompletterar varandra i att belysa individens upplevelse av kontroll såväl som de sociala processer som påverkar denna. Dessa begrepp är särskilt relevanta i relation till unga vuxna med psykisk ohälsa, då gruppen ofta befinner sig i en utsatt livssituation där frågor om stigma, självbestämmande och möjligheten att påverka stödinsatser kan få stor betydelse i mötet med socialtjänsten. De ger också ett teoretiskt ramverk som gör det möjligt med en djupare analys av hur unga vuxna med psykisk ohälsa upplever bemötande, delaktighet och stöd i kontakten med socialtjänst.

4. Metod

4.1 Materialinsamling och urval

Materialinsamlingen i den här studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Denna metod är vanlig inom kvalitativ forskning, eftersom den är flexibel och ger möjlighet till att fånga deltagarnas egna upplevelser och perspektiv på ett djupare plan (Bryman 2018, s. 518).

Urvalet i studien genomfördes genom ett *strategiskt urval.* Till att börja med formulerades vissa kriterier för vilka som kunde delta, exempelvis att intervjupersonerna skulle vara unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa och har haft erfarenhet av kontakt med socialtjänsten. Eftersom många kan uppfylla dessa kriterier gjordes sedan ett mer medvetet urval, där intervjupersoner valdes ut utifrån deras relevans för studiens syfte. Urvalet kan liknas vid det tillvägagångssättet som Falkheimer beskriver, där urvalet sker i två steg, där kriterier inledningsvis fastställs och därefter kompletteras genom ett strategiskt urval (Falkheimer 2014, s. 191-192). Rekryteringen av intervjupersoner skedde via digitala sociala medier, till exempel genom inlägg i relevanta grupper på Facebook, där personer är villiga att diskutera psykisk ohälsa eller erfarenheter av stöd från olika samhällsinsatser, och i detta fall socialtjänsten. Det publicerades varsitt inlägg i dessa Facebookgrupper: “Ångestgruppen - förbättra psykisk ohälsa”, “Psykisk ohälsa”, “Stödgrupp för dig med psykisk ohälsa”. Genom att vi publicerade ett informationsbrev i dessa grupper fick individer som uppfyller studiens kriterier möjlighet att själva träda fram och anmäla intresse för att vara delaktiga i studien. Efter att vi publicerade inlägget på Facebook, hörde personer av sig både på Facebook (via messenger) och till våra mejl. Vi var tydliga med att vi inte ville få kontakt direkt via inlägget, då vi ville undvika identifiering av deltagare. Vi valde att fokusera på dem som mejlade oss, eftersom vi fick snabbare svar, samt att de personerna utifrån första intrycket var seriösa med att delta. Intervjupersonerna i studien bestod av unga vuxna i åldern cirka tjugo till tjugosju år, som har haft kontakt med socialtjänsten i samband med psykisk ohälsa. Urvalet omfattade tre män och tre kvinnor. Vi eftersträvade en jämn könsfördelning för att få variation i erfarenheter och perspektiv och inte ha fokus på könsskillnader.

Det finns samtidigt vissa begränsningar med denna typ av urval. Individer som deltar i sådana onlinegrupper kan till exempel skilja sig från andra individer med liknande

erfarenheter. Det betyder att urvalet inte nödvändigtvis representerar alla unga vuxna med psykisk ohälsa. Dock syftar inte studien till att representera en hel population, utan meningen med studien är att få en djupare förståelse av intervjupersonernas erfarenheter.

Semistrukturerade intervjuer utgick från en intervjuguide med ett antal förberedda frågor, där det finns plats för att anpassa intervjun utifrån intervjupersonernas svar (Bryman 2018, s. 518-519). Det gjorde det möjligt för oss att ställa följdfrågor, ändra ordningsföljden på frågorna och samtidigt fånga upp nya teman som uppstod under intervjun. För att uppmuntra intervjupersonerna att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser i egna ord har intervjuerna utgått från öppna frågor. Fokus var att få fylliga och nyanserade svar, vilket står i centrum inom kvalitativa intervjuer där forskarens intresse ligger i hur individer tänker och känner kring ett visst fenomen. Vi underlättade jämförelserna mellan intervjupersonernas svar genom en intervjuguide som säkerställer att alla relevanta teman är kopplade till studiens syfte behandlas (Bryman 2018, s. 519-520).

När det kommer till hur vi utformade intervjuguiden, lades det särskild vikt på att frågorna var begripliga, öppna och kopplade till studiens forskningsfrågor, vilket enligt Bryman ska vara en del av utformningen (Bryman 2018, s. 522-523). Intervjufrågorna var utformade utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Teman som bemötande, delaktighet och upplevelser av stöd från socialtjänsten fanns med i intervjuguiden. Inledningsvis innehöll intervjuguiden allmänna frågor om intervjupersonernas erfarenheter av kontakt med socialtjänsten och övergick sedan till mer ingående frågor om deras och upplevelser av mötet med socialtjänsten.

Intervjuerna genomfördes digitalt via Zoom och Microsoft Teams. Det möjliggjorde en flexibel och tidseffektiv datainsamling, eftersom det minskade behovet av resor och gjorde det enklare att inkludera deltagare från olika geografiska områden (Bryman 2018, s. 249-250). Digitala intervjuer kan vara särskilt lämpliga när ämnet kan upplevas som känsligt.

Intervjuerna tog mellan fyrtiofem till sextio minuter. Alla sex intervjupersonerna samtyckte till ljudinspelning. Meningen med det är för att säkerställa att materialet kan analyseras noggrant i efterhand. Därefter transkriberades inspelningarna, samt anonymiserades. Två av de intervjuade kvinnorna var 26 år gamla, medan den tredje var 22 år. Bland männen var två intervjupersoner 24 år och en intervjuperson 21 år. Intervjupersonerna hade varierande erfarenheter av kontakt med socialtjänsten, både vad gäller omfattning och typ av insatser. Flera har haft långvarig kontakt med socialtjänsten och erfarenheter av psykisk ohälsa i

kombination med social problematik, vilket syftar på ekonomiska svårigheter, familjekonflikter eller social isolering.

4.2 Bearbetning och analys av materialet

Val av metod för denna studie är tematisk analys. Denna metod lämpar sig väl för studien när det kommer till att identifiera, analysera och tolka mönster (teman) i intervjupersonernas berättelser. Teman kan förstås som kategorier som genereras ur data, är kopplade till studiens syfte och bygger på identifierade koder (Bryman 2018, s. 657). Tematisk analys passar bra för studiens syfte, eftersom den fångar nyanser, känslor och den komplexitet som ofta präglar mötet med socialtjänsten.

Braun och Clarke (2006) beskriver sex steg som har följts i analysprocessen med hjälp av den tematiska analysen. I det första steget bekantade sig uppsatsstudenterna med materialet, genom att transkribera intervjuerna och läsa igenom dem flera gånger för att skapa en helhetsförståelse, samt en initial känsla för återkommande mönster och betydelsebärande innehåll. Under detta steg fördes också anteckningar kring spontana reflektioner och potentiella tolkningsspår. Det andra steget inleddes med den initiala kodningen, där relevanta delar av materialet markerades och fick etiketter som fångar viktiga aspekter av materialet. Kodningen var induktiv, vilket betyder att koderna genererades direkt ur materialet snarare än att utgå från förutbestämda kategorier. Kodningen genomfördes inledningsvis empirinära och induktivt, där koderna utvecklades utifrån intervjupersonernas berättelser snarare än förutbestämda teoretiska kategorier. *Empowerment* och *stigma* användes därefter som analytiska verktyg för att tolka och fördjupa förståelsen av de framväxande temana. *Empowerment* kan användas för att identifiera teman som handlar om delaktighet, inflytande, autonomi och upplevelser av stöd. *Stigma* kan användas för att identifiera teman som rör bemötande, kategorisering, normer och social identitet. Till exempel kan utsagor om att “inte bli lyssnad på” tolkas både som brist på *empowerment* och som en konsekvens av stigmatiserande föreställningar. Relevanta delar av texten markerades och tilldelades korta, beskrivande etiketter som fångade centrala aspekter av intervjupersonernas upplevelser, exempelvis “objektifiering”, “maktlöshet”, “icke-dömande bemötande” och “bristande delaktighet”. Kodningen genomfördes systematiskt över hela materialet för att säkerställa att relevanta aspekter inkluderades. I det tredje steget analyserades koderna genom att jämföras och grupperas utifrån likheter och samband. Detta resulterade i att preliminära teman växte

fram som representerade återkommande mönster i materialet. Genom jämförelser mellan koderna identifierades återkommande mönster och erfarenheter, vilket senare utvecklades till preliminära teman. I denna fas började analysen röra sig från en deskriptiv nivå mot en mer tolkande förståelse.

I det fjärde steget granskades temana noggrant, där dessa utvecklades vidare genom att förfinas, slås ihop och delas upp i underteman för att göra analysen tydligare. Vissa teman omformulerades för att bättre spegla materialets innehåll. I detta skede kontrollerade också att varje tema var internt likartad och externt tydlig, vilket betyder att innehållet inom ett tema hörde ihop samtidigt som det tydligt skilde sig från övriga teman. I det femte steget arbetade uppsatsstudenterna vidare med att tydligt definiera och namnge temana mer precist. Det innebär att varje tema beskrevs på ett sätt som klargör vad det handlar om och hur det hänger ihop med de andra temana, men även i relation till studiens syfte och frågeställningar. Underteman utvecklades för att synliggöra variationer inom respektive tema, till exempel skillnaden mellan att bli sedd som individ och att bli behandlad som ett ärende. Avslutningsvis stärktes analysen i det sjätte steget genom att teman bestyrktes med hjälp av citat och konkreta exempel från materialet, samtidigt som de kopplades till tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk, alltså empowerment och stigma. Dessa citat valdes ut för att tydligt illustrera de identifierade temana och ge röst åt intervjupersonernas erfarenheter. Analysprocessen var dessutom iterativ, vilket betyder att forskaren rör sig fram och tillbaka mellan olika steg och successivt fördjupar sin förståelse av materialet (Bryman 2018, s. 658).

Genom att använda tematisk analys blev det möjligt att identifiera både likheter och skillnader i intervjupersonernas berättelser, vilket bidrog till en mer nyanserad förståelse av hur unga vuxna upplever mötet med socialtjänsten.

4.3 Metodologiska reflektioner

Det finns flera utmaningar med val av metod. En sådan metodologisk utmaning är att intervjupersonernas berättelser är retrospektiva, vilket innebär att de kan påverkas av minnesförskjutningar eller efterhandskonstruktioner. Detta kan ha påverkat hur intervjupersonerna beskrev sina möten med socialtjänsten, då erfarenheterna återgavs i efterhand och kan ha färgats av senare upplevelser och reflektioner. Samtidigt möjliggjorde det retrospektiva perspektivet att intervjupersonerna kunde reflektera mer övergripande kring betydelsen av mötena. Vi är även medvetna om att digitala intervjuer kan innebära begränsningar, exempelvis att kroppsspråk blir svårare att tolka. Samtidigt kunde det också

skapa trygghet för intervjupersonerna eftersom de intervjuades i en miljö där de kände sig bekväma.

Det finns även en risk för selektionsbias, då de som valde att delta kan ha särskilt starka positiva eller negativa erfarenheter av socialtjänsten. Detta kan ha påverkat resultatet genom att vissa typer av erfarenheter framträdde tydligare än andra. För att hantera detta eftersträvades variation i intervjupersonernas erfarenheter och berättelser under rekryteringsprocessen.

Vidare kan uppsatsstudenternas tolkningar ha påverkat analysen. Eftersom tematisk analys är en tolkande metod, finns en risk att forskarens teoretiska perspektiv, såsom empowerment och stigma, har påverkat vilka mönster som uppmärksammades i materialet. För att minska denna påverkan genomfördes kodningen inledningsvis empirinära och induktivt innan materialet tolkades utifrån de teoretiska perspektiven.

4.4 Förförståelse

Forskarens förförståelse har stor betydelse för hur forskningsfrågor formuleras såväl som vilka resultat som uppnås. Den påverkar hur forskaren tänker och formar typen av kunskapsproduktion (Åkerström 2014, s. 249). Denna förförståelse bygger på forskarens vetenskapsteoretiska antaganden, som ontologi och epistemologi, vilka formar hur verkligheten uppfattas och hur kunskap anses kunna nås (Åkerström 2014, s. 252-253).

Trots att dessa antaganden ofta är omedvetna, påverkar de både val av metod och hur materialet tolkas. Det kan leda till att olika forskare kommer fram till olika resultat, även om de undersöker samma frågeställning (Åkerström 2014, s. 251). Därför är det viktigt att reflektera över och synliggöra sin egen förförståelse eftersom det bidrar till större transparens och gör det lättare att ge en mer rättvisande och allsidig bild av verkligheten. Detta stärker studiens vetenskapliga och samhälleliga relevans (Åkerström 2014, s. 253).

I denna studie har vi som uppsatsstudenter en utbildningsbakgrund inom socialt arbete, vilket betyder att vi har viss kunskap om socialtjänstens uppdrag och arbetssätt. Denna kunskap kan bidra till en ökad förståelse för det sammanhang som studien behandlar. Samtidigt är vi medvetna om att våra egna perspektiv kan påverka hur intervjumaterialet tolkas. För att hantera detta har vi strävat efter att vara reflexiva under forskningsprocessen. Det betyder att

konstant reflektera över hur vår egen förförståelse kan påverka tolkningen av materialet och försöka hålla en öppen ställning till intervjupersonernas berättelser. Eftersom vi är två studenter i studien har vi också olika förförståelser, vilket kan påverka hur vi tolkar materialet. Genom att diskutera våra tolkningar med varandra har vi kunnat synliggöra dessa skillnader och därmed få en mer nyanserad förförståelse av empirin.

4.5 Etiska reflektioner

Vid intervjuer i forskning är det viktigt att intervjupersonerna får tydlig och tillräcklig information i förväg. De ska informeras om syftet med studien, hur intervjun kommer att genomföras och hur materialet kommer att användas. Denna information ges innan intervjun inleds för att möjliggöra ett informerat samtycke. Det är även viktigt att intervjupersonerna får möjlighet att ställa frågor, för att klargöra eventuella oklarheter och förstå vad deras deltagande innebär (Vetenskapsrådet 2024, s. 87, 89).

Deltagandet är alltid frivilligt och intervjupersonerna har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva ange någon orsak (Vetenskapsrådet 2024, 87, 101). Samtycket kan antingen samlas in skriftligt eller muntligt, men det ska vara informerat. Det innebär att intervjupersonerna måste vara fullt medvetna om vad de går med på och vilka risker och fördelar som kan förekomma (Vetenskapsrådet 2024, 89). Eftersom ämnet är känsligt ska särskilda skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa intervjupersonernas välbefinnande, vilket kan inkludera möjligheten att avstå från att svara på enskilda frågor och tillhandahålla stöd vid behov (Vetenskapsrådet 2024, 87, 101).

Intervjupersonernas identitet ska skyddas genom att anonymiseras där personuppgifter och andra känsliga uppgifter tas bort eller inte blir tillgängliga för obehöriga. Utifrån studiens art beror det på vad som ska anonymiseras, men syftar till att förhindra att enskilda kan identifieras (Vetenskapsrådet 2024, s. 87, 102). Endast forskargruppen (vilket inkluderar oss studenter som genomför studien under handledning, samt den skola som ansvarar för forskningsprojektet och dess datainsamling), har tillgång till det insamlade materialet och samtyckesblanketterna medan studien pågår. Efter avslutad studie ska materialet hanteras i enlighet med gällande lagar och regelverk, vilket kan innebära arkivering eller radering (Vetenskapsrådet 2024, s. 97, 102).

Dessa principer bidrar till att säkerställa att forskningen bedrivs med ansvar och respekt för intervjupersonernas rättigheter och integritet.

4.6 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet

Inom kvalitativ forskning använder man ofta andra sätt att bedöma kvalitet än i kvantitativa studier. Tre viktiga begrepp är trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet kan jämföras med intern validitet och handlar om hur väl resultaten speglar den verklighet som studerats. För att stärka trovärdigheten behöver forskaren arbeta noggrant med sin analys, tolka materialet på ett genomtänkt sätt och visa att resultaten är rimliga och välgrundade (Bryman 2018, s. 67). I denna studie stärks trovärdigheten genom att intervjuerna transkriberades noggrant och analyserades systematiskt med hjälp av tematisk analys. Genom att använda citat från intervjuerna i resultatredovisningen ges läsaren möjlighet att själv ta del av intervjupersonernas perspektiv.

Pålitlighet som motsvarar reliabilitet, handlar om studiens stabilitet över tid. Eftersom kvalitativ forskning ofta är bunden av kontext är det inte enkelt att uppnå exakt samma resultat vid upprepning, men transparens i forskningsprocessen kan öka pålitligheten. Överförbarhet motsvarar extern validitet och innebär i vilken utsträckning resultaten kan tillämpas i andra sammanhang. Här har forskaren ansvar att ge tillräckligt rika beskrivningar så att läsaren kan avgöra om resultaten är relevanta i andra kontexter (Bryman 2018, s. 67). Kvalitativ forskning har även ofta hög ekologisk validitet, eftersom data samlas in i naturliga miljöer (Bryman 2018, s. 68).

Eftersom studien baseras på ett begränsat antal intervjuer är inte resultaten generaliserbara. Däremot kan resultaten bidra till analytisk generalisering, där resultaten kan ge insikter som kan vara relevanta även i andra liknande sammanhang.

5. Resultat och analys

Den tematiska analysen utgick från återkommande koder i intervjumaterialet, vilka därefter grupperades till fem huvudsakliga teman. Dessa teman tolkas i analysen med hjälp av empowerment och stigma, men har sin utgångspunkt i de empiriska mönster som framkom i materialet. Studiens resultat tyder på att unga vuxnas upplevelser av mötet med socialtjänsten i hög grad kan förstås genom ett empowermentperspektiv. Empowerment innebär, enligt Askheim (2007, s. 18), en process där individer får möjlighet att stärka kontrollen över sina liv och de beslut som påverkar dem. Centralt i detta är self-determination och agency, alltså både individens rätt att fatta egna beslut och förmågan att omsätta dem i handling (Askheim 2007, s. 26-27). Samtidigt visar analysen att dessa aspekter ofta är begränsade i intervjupersonernas erfarenheter, särskilt i början av kontakten med socialtjänsten. Studiens resultat visar även att stigma är en central och genomgående dimension i unga vuxnas upplevelser av mötet med socialtjänsten. Enligt Goffmans teori om stigma (1963) kan man förstå begreppet som en social process där individer tillskrivs negativa egenskaper som avviker från samhällets normer, vilket leder till att deras sociala identitet nedvärderas (Goffman 2012, s. 5). Stigma ska förstås i vår studie som både ett eget tema, men även en återkommande dimension i flera teman. Vår analys av resultatet visar att denna process inte endast är närvarande, utan även aktivt formar intervjupersonernas erfarenheter av bemötande, delaktighet och stöd.

Den tematiska analysen resulterade i fem huvudsakliga teman: *bemötande i mötet med socialtjänsten, delaktighet och inflytande, stöd i relation till behov, stigma och självbild,* samt *strukturella hinder och möjligheter.* Resultaten visar både variationer och tydliga mönster i intervjupersonernas upplevelser. Framförallt är det bemötandet och känslan av delaktighet som framstår som avgörande faktorer i hur människor upplever sin situation.

Bemötande i mötet med socialtjänsten

Det första framträdande temat i empirin är bemötande i mötet med socialtjänsten. Bemötandet framstår som centralt för hur intervjupersonerna upplever kontakten med socialtjänsten. Några beskriver negativa erfarenheter av att inte bli sedda som individer, vilket leder till att de kategoriseras och ses som problem. En intervjuperson uttrycker:

“Ehmm… jag kände mig typ… som ett problem. Inte som en person. Tänkte ’är det det här jag kom hit för?’”(Y).

En annan beskriver att hon blev bemött:

“mer som ett ärende” (C).

I kontrast visar resultatet att ett bristande bemötande kan göra det svårare för empowerment att utvecklas. När intervjupersoner beskriver att de blivit behandlade som “problem” eller “ärenden”, kan detta tolkas som att de inte erkänns som aktiva subjekt med egna resurser och erfarenheter. Detta står i parallell med Bark et al. (2023, s. 3, 13), som menar att socialt arbete inom psykiatrin ofta marginaliseras till förmån för mer standardiserade och biomedicinska perspektiv. När fokus i högre grad riktas mot problem och diagnoser snarare än individens livssituation och resurser, minskar utrymmet för ett arbetssätt som främjar empowerment.

Även diskreta uttryck för dömande bemötande framkommer, där en intervjuperson menar att:

“Ja… absolut. Ung kille som blivit skjuten, droger, avhoppad skola… de tänker ju sitt direkt.” (Y).

“man känner det… i blickar… i hur de pratar” (B).

Resultatet visar också att stigma inte endast uttrycks konkret, utan ofta genom diskreta signaler. Flera intervjupersoner beskriver att de känner sig dömda genom blickar, tonfall eller socialarbetarens kommunikationssätt och kroppsspråk. Detta går i linje med Goffmans (2012, s. 27) beskrivning av sociala interaktioner mellan stigmatiserade och “normala” individer, där osäkerhet och obehag kan ta sig uttryck i indirekta beteenden. Stigma behöver inte alltid uttryckas verbalt, vilket individen kan snappa upp och uppleva det tydligt, vilket påverkar relationen till socialarbetaren negativt.

“Jag kände mig också… väldigt liten. Som att mitt liv bara… bestämdes över mitt huvud” (B).

"Den första… alltså… han var inte bra. Han var väldigt såhär… strikt. Typ 'du måste sluta, annars kommer det gå illa'. Och jag fattar ju det nu… men då… det funkade inte på mig. Speciellt med mitt temperament. Jag tyckte bara han försökte leka macho på mitt huvud" (Y).

En betydande konsekvens av dessa erfarenheter är att intervjupersonerna utvecklar strategier för att hantera stigma. Som en följd av tidigare negativa bemötanden beskriver flera intervjupersoner att de helst håller tillbaka information eller anpassar sina berättelser i mötet med socialtjänsten. Detta kan ses som en form av informationskontroll, där individen försöker påverka hur den uppfattas av andra (Goffman 2012, s. 46). Genom att till exempel undvika att säga vissa känsliga uppgifter eller säga det som förväntas, försöker individen undvika ytterligare stigmatisering. Denna strategi har dock konsekvenser för stödet. När klienten inte känner en trygg känsla av att vara öppen, riskerar socialtjänsten att få en ofullständig bild av hens situation. Det kan leda till att de behoven som faktiskt finns inte ges insatser som är anpassade, vilket i sin tur kan förstärka känslan av att bli missförstådd. Detta kan kopplas till Sheikhan et al. (2023, s. 8) som menar att stigma kan leda till att unga undviker att söka hjälp eller inte uttrycker sina behov fullt ut.

Samtidigt framkommer att ett empatiskt och icke-dömande bemötande kan få stor betydelse. När socialarbetare visade förståelse och lyssnade aktivt skapades förutsättningar för tillit. Några intervjupersoner beskriver ett sådant möte:

"Jag minns att jag kom dit en gång, helt förstörd… jag hade återfallit igen. Och jag var typ redo att få en utskällning. Men hon bara… "okej, berätta vad som hände" (Y).

"Hon var… ganska lugn ändå. Inte dömande, vilket jag typ förväntade mig" (E).

"Och jag trodde de skulle skälla ut mig… men istället så frågade hon typ: 'vad var det som hände innan?' (paus) Och det var första gången någon brydde sig om varför" (E).

Dessa situationer beskrivs som avgörande för att våga öppna sig och fortsätta kontakten. Bemötandet framstår även som avgörande för om empowerment faktiskt blir möjlig eller begränsas. När intervjupersoner beskriver att de möts med förståelse, respekt och ett icke-dömande förhållningssätt, skapas förutsättningar för att de vågar uttrycka sina behov och delta aktivt i processen. Detta kan förstås i relation till Gebert och Lowe (2025, s. 396, 404-405), som betonar vikten av ett systemteoretiskt och trauma-informerat perspektiv inom socialt arbete. Genom att se individens situation i ett större sammanhang, där både sociala

och psykologiska faktorer samspelar, kan socialarbetare skapa mer individanpassade och meningsfulla insatser.

"Jag berättade om att jag hade bott på en busstationstoalett i flera månader… Och hon bara stannade upp och… sa typ 'det här är inte okej'."...."Att hon reagerade. Att hon inte bara skrev ner det… utan faktiskt kände något" ©

"Generellt… ganska bra faktiskt. Alltså… inte perfekt… men jag kände mig oftast respekterad"...."Jag vågade vara mer ärlig. Jag behövde inte låtsas att det gick bättre än det gjorde" (M).

Liknande erfarenheter uttrycks av en annan intervjuperson, exempelvis:

"Och jag var beredd på att hon skulle bli arg eller typ… säga att jag måste sluta. Men hon sa bara: 'okej… vad hände innan det?'…Det var första gången någon frågade så" (S).

"Jag satt där med armarna i kors, sa typ ingenting. Kollade ner i golvet mest. Tänkte bara 'snälla låt det här gå över snabbt'. Jag tror jag skämdes faktiskt. Men… ehmm… hon som jag träffade var ganska lugn. Hon pressade mig inte direkt, utan sa typ 'du behöver inte berätta allt idag'. Samtidigt som det var en lättnad att inte spilla ut allting ville jag ändå bara berätta allt för att det någon gång skulle ta stopp. Och det… alltså det gjorde ändå något att hon inte pressade mig. Jag kände mig inte attackerad" (S).

Delaktighet och inflytande

Ett centralt mönster i empirin beskriver intervjupersonernas delaktighet och inflytande. Ett genomgående samtalsämne är upplevelsen av begränsad delaktighet, särskilt i inledningen av kontakten. Flera intervjupersoner beskriver att beslut fattades utan deras inflytande, vilket skapade känslor av maktlöshet. En intervjuperson uttrycker:

"Det var mer som att de sa 'det här är planen'" (Y)...."Ja… typ när de skickade mig till avgiftning första gången. Jag fattade inte riktigt vad som hände ens" (Y).

Medan en annan beskriver delaktigheten som *"typ noll" (B).*

Ett tydligt återkommande mönster i resultatet är att fyra intervjupersoner upplever en begränsad delaktighet i beslutsprocesser. Beskrivningar av hur socialtjänsten presenterade

färdiga planer, eller hur delaktigheten upplevdes som *"typ noll",* indikerar en låg grad av self-determination. Detta innebär att individerna ges därmed liten möjlighet att påverka sin egen situation, vilket är centralt för att empowerment ska kunna uppnås (Askheim 2007, s. 18).

Denna brist på inflytande påverkar upplevelsen av kontroll över den egna situationen. En intervjuperson beskriver:

"Jag kände att jag inte hade kontroll över någonting" (Y),

medan andra uttrycker att:

"Jag kände att mitt liv inte var mitt. Att andra bestämde. Började tänka 'vad ska hända med mig nu?' Samtidigt som jag kanske kände 'yes, jag slipper min farsa'. Det var blandade känslor" (S).

"Den blev bättre med tiden. I början kände jag typ inget inflytande" (E).

"Ehmm… det kändes som att besluten redan var tagna faktiskt"...."Ja… typ när de tog bort min lägenhet. Det bara… hände."...."Det var… knas. Alltså… jag blev hemlös igen."....."Jag hade ingen kontroll alls."....."Det var ingen balans… nej, ingen alls."....."Nej… inte riktigt. Det var mycket regler och saker man inte fick insyn i" (C).

Avsaknaden av inflytande kan förstås som kopplat till känslor av maktlöshet, där intervjupersonerna beskriver att de saknar kontroll över både beslut och livssituation. Denna upplevelse kan förstås i relation till Askheims (2007, s. 50-51) resonemang om empowerment som en möjlig form av styrning. Trots att socialtjänstens arbete formellt syftar till att stärka individens självständighet, sker det ofta inom ramar som individen själv har begränsat inflytande över. Resultatet visar till exempel att intervjupersoner förväntas följa insatser som de inte själva varit delaktiga i att utforma. Detta skapar en paradox där individen förväntas ta ansvar för sin egen förändring, samtidigt som handlingsutrymmet är begränsat.

I vissa fall ledde detta till motstånd, exempelvis att avbryta kontakten eller rymma från placeringar. Å andra sidan framkommer att delaktigheten i vissa fall ökade över tid. När intervjupersoner fick vara med och sätta mål eller påverka insatser förändrades upplevelsen. Två intervjupersoner beskriver detta som:

"Vi satte typ mål tillsammans… små steg" (M), vilket bidrog till att "jag fick tillbaka lite kontroll över mitt liv" (M).

"Inte i början… men senare ja. Hon jag hade i slutet var väldigt bra med att förklara saker som skulle ske och varför det ska ske. Jag kände då att jag kunde förstå besluten" (E).

Samtidigt visar studiens resultat att empowerment kan utvecklas över tid, särskilt när relationen mellan individ och socialarbetare präglas av tillit och respekt. När intervjupersonerna upplever att de får vara delaktiga i att sätta mål eller påverka insatser, skiftar deras upplevelse från maktlöshet till en känsla av kontroll. Detta återspeglar en ökad grad av agency, där individen inte längre framstår som en passiv mottagare av stöd, utan som en aktiv aktör i sin egen förändringsprocess (Askheim 2007, s. 26-27).

Denna utveckling ligger i linje med tidigare forskning som lyfter fram hur viktig delaktighet och individanpassning är. Broad et al. (2017, s. 10) visar till exempel att unga som får vara med att delta i planeringen av sin vård oftare upplever stödet som mer sammanhängande och meningsfullt. På liknande sätt betonar Beckwith et al. (2021, s. 113-114) att personcentrerade insatser och ett tillitsfullt samarbete mellan klient och professionella är avgörande för att skapa engagemang och främja återhämtning. Resultatet i denna studie bekräftar dessa fynd, då intervjupersoner som upplever ökad delaktighet också beskriver en tydligare känsla av kontroll och ökad motivation.

Stöd i relation till behov

Det tredje temat är stöd i relation till behov, där intervjupersonerna upplever att stödet varierar avsevärt. Vissa beskriver insatser som fungerat väl, särskilt när de varit individanpassade och kontinuerliga. En intervjuperson framhåller exempelvis att:

"Behandlingshemmet… det var det som hjälpte på riktigt. Jag började äta bra, må bra och träna mycket"(Y).

"Det hjälpte mig att… känna igen mig själv igen. Alltså… jag började träna där, och det var första gången på länge jag kände något som inte var ångest"(Y).

medan andra beskriver stödet som:

“ganska konkret… små saker som blev stora för mig”....“Jag började se mig själv som någon som kunde… förändras.” (M).

“Mycket samtal… både enskilt och med familjen. Och typ… de hjälpte mig strukturera upp skolan” (E).

En aspekt som framträder i analysen är att intervjupersonerna beskrev en balans mellan stöd och kontroll i mötet med socialtjänsten. Flera berättelser visade hur regler, bedömningar och myndighetsutövning ibland kunde begränsa känslan av självbestämmande. Samtidigt framkom att upplevelser av delaktighet och empowerment kunde stärkas när socialarbetare kombinerade struktur med flexibilitet och ett relationsinriktat arbetssätt. Detta kan förstås utifrån Askheim (2007, s. 29-31), som beskriver vikten av en positiv människosyn, där individen ses som kapabel att fatta egna beslut och bidra till sin egen förändring. I de här situationerna verkar stödet upplevas som mer meningsfullt och inkluderande.

Flera intervjupersoner uttrycker däremot att stödet ofta inte motsvarade deras behov. En intervjuperson beskriver:

“Jag behövde trygghet… men fick osäkerhet” (C).

och ett enskilt men allvarligt exempel från en intervjuperson visar:

“Sen försökte de med familjesamtal också… men ehh… det funkade inte så bra. Min pappa satt mest tyst eller blev arg efteråt hemma. På köpet fick jag ännu mer slag från honom. Å jag vågade inte berätta det för soc. Så att involvera min familj var nog inte sådär jätte bra…” (S).

Resultatet visar att denna spänning påverkar intervjupersonernas upplevelse av empowerment, eftersom de ibland upplever att kontrollen vissa situationer dominerar över stödinsatserna. När stödet inte upplevs vara anpassat efter individens behov, riskerar det istället att skapa känslor av otrygghet och bristande tillit. Detta blir särskilt tydligt i situationer där insatser upplevs som standardiserade snarare än individanpassade.

Bristande kontinuitet lyfts också, exempelvis:

“När man kommer ut… det är då det är svårt egentligen” (Y), vilket pekar på behov av uppföljning.

"Jag tappade förtroendet. Jag slutade prata öppet. Inte för att jag någon gång pratade helt öppet men man försökte ju. Men till slut gav jag upp" (B).

"Boende ett tag… sen inget. Lite pengar ibland… men ofta avslag" (C).

Stigma har även en påverkan på intervjupersonernas tillit till socialtjänsten. De intervjupersonerna som beskriver att de tappar förtroendet, menar på att de känt sig missförstådda eller dömda. Detta leder i vissa fall till att de har avbrutit kontakten eller blivit mindre benägna att söka hjälp i framtiden. Denna utveckling kan förstås i relation till Westberg et al. (2020, s. 6, 8-9), som visar hur unga kan känna sig vilsna i mötet med stödsystem och uppleva bristande tillgänglighet och förståelse. När stigma förstärker känslan av osäkerhet, tenderar individen att dra sig undan från systemet.

Stigma och självbild

Upplevelser av stigma är tydligt närvarande i materialet. Flera intervjupersoner beskriver hur de kategoriseras utifrån sina problem, exempelvis:

"Då var jag bara 'missbrukare'" (Y).

"hon med problem" (B).

Även sociala kategoriseringar framkommer, som i uttrycket:

"Typ invandrartjej, problem hemma… då blir man en viss 'typ' i deras ögon"…"Jag kände mig som ett problem länge. Inte bara ett problem utan att jag hade flera problem. Började nästan ge upp på mig själv" (S).

Ett återkommande mönster i resultatet är att intervjupersonerna upplever att de kategoriseras utifrån sina problem och livssituationer. Där inkluderas beskrivningar som att bli sedd som "missbrukare", "problematisk" eller "ett ärende", vilket indikerar på att deras identitet reduceras till specifika egenskaper eller beteenden. Detta kan ses som en diskrepans mellan individens faktiska sociala identitet och den virtuella sociala identitet som tillskrivs dem av omgivningen (Goffman 2012, s. 10-11). Stigma uppstår då när denna diskrepans blir tydlig, vilket påverkar hur individen blir bemött och hur individen ser på sig själv.

Den här typen av kategorisering kan också kopplas till begreppet social information, där individens egenskaper tolkas och värderas i sociala interaktioner (Goffman 2012, s. 5). I mötet med socialtjänsten blir intervjupersonernas bakgrund, till exempel psykisk ohälsa i kombination med missbruk eller dålig familjesituation, centrala markörer som formar hur de uppfattas. Detta betyder att det finns en risk för att individen blir definierad utifrån en avvikelse snarare än att ses i sin helhet.

Dessa erfarenheter påverkar självbilden. En intervjuperson beskriver:

"Jag började känna mig som ett 'problem'" (C), medan en annan uttrycker att hon kände sig "ännu mer… trasig" (B).

En annan berättar:

"Jag såg mig själv som en förlorare länge. Mina suicidtankar började också komma fram" (Y).

Resultatet visar vidare att stigma påverkar intervjupersonernas självbild. Några av intervjupersonerna beskriver att de internaliserar de negativa föreställningar som de möter, till exempel genom att börja se sig själva som "problem" eller "trasiga". Detta kan förstås som internaliserat stigma, där individen tar till sig omgivningens negativa syn och gör den till en del av sin egen identitet. Goffman (2012, s. 44) menar att detta kan leda till att individen inte känner sig värdefull och upplever en distans till andra individer.

Den här processen står i linje med Nord-Baade et al. (2025, s. 7), som beskriver att unga vuxna med psykisk ohälsa ofta upplever en negativ självbild och en känsla av utanförskap gentemot samhället. Forskarna menar att dessa subjektiva aspekter av identitet är centrala för social inkludering, men ofta förbises inom vård och stödinsatser. Resultatet i denna studie visar att bemötandet från socialtjänsten kan antingen bidra till att förstärka eller motverka denna negativa självbild.

Flera beskriver också strategier för att hantera detta, exempelvis att anpassa sig:

"Jag sa det jag trodde de ville höra" och "För jag kände att det inte skulle göra någon skillnad" (B).

"Jag började öppna mig mer. Först var jag lite rädd att öppna upp mig för mina vänner skulle kalla mig för golare och att jag samarbetar med en myndighet som för den delen har

ett dåligt rykte eller vad man ska säga, plus att jag inte ville vara en miskin, aså en sån som typ sätter på sig en offerkofta och leker oskyldig" (E).

En annan aspekt som framhävs i resultatet är att stigma också är kopplat till sociala och strukturella aspekter. Det innebär att flera intervjupersoner beskriver att deras bakgrund, såsom kön, etnicitet eller bostadsområde påverkar hur de bemöts. Detta kan förstås som en form av social kategorisering där vissa grupper tillskrivs särskilda egenskaper (Goffman 2012, s. 5). Denna typ av stigma är inte bara individuell, utan också strukturell, då den reproduceras genom institutionella praktiker och normer. Detta kan kopplas till Hulin et al. (2024, s. 4-5) som betonar att bristande förståelse för individuella behov och erfarenheter kan leda till att individer känner sig marginaliserade inom stödsystemet. När socialtjänsten inte tar hänsyn till individens kontext, riskerar stödet att upplevas som relevant eller otillräckligt.

Strukturella hinder och möjligheter

I materialet visar sig strukturella faktorer vara betydelsefulla. Flera intervjupersoner beskriver socialtjänsten som ett komplext och fragmenterat system:

"Att systemet inte hängde ihop. Alltså… soc, vård, frivård… allt var separat. Man fick ringa hit och dit, man fick ta mycket ansvar. Det va jättesvårt, speciellt när man inte ens pallade med sig själv" (Y).

Regler och riktlinjer upplevs som begränsande:

"Ja… reglerna. De kändes… fyrkantiga." (C) och "det kändes stelt" (M), samt "Systemet. Tider, regler… det var segt" (S).

"Och att systemet var så… stelt. Det var som att de inte kunde tänka utanför boxen"(B).

Resultatet visar även att empowerment inte endast formas i mötet mellan individ och socialarbetare, utan i hög grad påverkas av strukturella villkor. Flera intervjupersoner beskriver att socialtjänsten är ett system präglat av regler, begränsningar och bristande flexibilitet. Detta påverkar inte enbart individens upplevelse, utan även socialarbetarens möjlighet att arbeta individanpassat. Detta ligger i linje med Askheim (2007, s. 22), som betonar att empowerment inte endast är en individuell process, utan även en strukturell sådan, där maktförhållanden och organisatoriska ramar blir avgörande.

Denna problematik bekräftas även i tidigare forskning. Westberg et al. (2020, s. 4, 8-9) visar till exempel att många unga upplever stödsystemet som fragmenterat och svårt att navigera, vilket kan leda till en känsla av att vara “lost in space”. Detta stämmer väl överens med studiens resultat, där intervjupersoner beskriver att de måste hantera kontakter med flera aktörer, vilket försvårar deras möjlighet att få sammanhängande stöd. På liknande sätt lyfter Hulin et al. (2024, s. 1, 4) fram bristande flexibilitet, långa väntetider och komplexa vårdvägar som hinder för att få adekvat stöd.

Samtidigt framhålls att relationen till enskilda socialarbetare ofta är avgörande. Tre intervjupersoner uttrycker:

"När man fick rätt person… när någon lyssnade utan att döma”....“Att någon bryr sig på riktigt. Inte bara gör sitt jobb. Jag fattar att alla inte kan göra sitt jobb 100%, men jag tycker att arbeta hos soc är ett jätteviktigt jobb där man borde vara fokuserad på klienten”(Y).

“Att lita på dem i början. Med tanke på att man hört många gånger att soc inte hjälper” (E).

“Kanske… någon gång när en kvinna där faktiskt satt kvar efter mötet och bara… frågade hur jag mådde på riktigt”(B).

Detta visar att individens erfarenhet i hög grad formas i mötet mellan strukturella ramar och relationella aspekter. Resultatet visar även att kontinuitet i stödet har stor betydelse för möjligheten till empowerment. Intervjupersoner som haft en stabil och långvarig kontakt med en socialarbetare beskriver ofta en mer positiv utveckling, medan bristande kontinuitet bidrar till osäkerhet och minskat förtroende. Detta ligger i linje med Munford och Sanders (2015, s. 429, 433), som framhåller att långsiktiga och samordnade insatser är centrala för att skapa positiva utfall för unga med komplexa behov.

Resultatet visar samtidigt att stigma inte är en statisk process, utan kan förändras i relationella sammanhang. När intervjupersonerna beskriver möten där de känt sig lyssnade på och bemötta utan att känna sig dömda, minskar upplevelsen av stigma. Detta kan bidra till att stärka individens självkänsla och viljan att vara delaktighet i sin förändringsprocess. Detta syns i studien som Johansen et al. (2024, s. 8) skrivit om, där det betonas vikten av tillitsfulla relationer där unga känner sig sedda som individer och inte som ett problem. Resultatet i vår studie går i linje med detta, då intervjupersonerna beskriver att sådana relationer gör det möjligt för ökad öppenhet och minskad skam.

När socialarbetare har fokus på individens resurser och inte deras brister, skapas en motkraft till stigma. Detta kan även ha en koppling till ett bredare perspektiv på socialt arbete, vilket visas i Gebert och Lowes (2025, s. 396, 404-405) studie, som lyfter vikten av att förstå psykisk ohälsa i ett systemiskt sammanhang, där sociala och strukturella aspekter beaktas. Ett sådant perspektiv kan hjälpa till att minska stigmatisering, eftersom individens problem inte ses som enbart individuella brister, utan som en del av en större kontext.

Sammanfattning av resultaten

Sammanfattningsvis visar analysen att empowerment i mötet med socialtjänsten är en komplex och dynamisk process som formas i samspelet mellan individ, relation och strukturella villkor. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning (Broad et al. (2017), Hulin et al. (2024), Munford & Sanders (2015), Johansen et al. (2024) Beckwith et al. (2021), Westberg et al. (2020), Bark et al (2023) och Gebert & Lowe (2025), som betonar vikten av delaktighet, individanpassning och tillitsfulla relationer. Samtidigt visar analysen att intervjupersonernas upplevelser av delaktighet och handlingsutrymme ibland påverkas av regler, bedömningar och myndighetsutövning i mötet med socialtjänsten. Resultatet visar även att stigma var en central aspekt i intervjupersonernas berättelser och påverkade deras självbild, tillit och vilja att söka eller ta emot stöd. För unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa tycks frågor om trygghet, bemötande och delaktighet få särskild betydelse, då psykisk ohälsa i vissa fall kunde påverka möjligheten att uttrycka behov, känna sig förstådd och orka navigera socialtjänstens processer. Analysen visar samtidigt att ett empatiskt och individanpassat bemötande kunde bidra till ökad tillit och känsla av delaktighet i kontakten med socialtjänsten.

6. Diskussion

Syftet med studien var att undersöka hur unga vuxna med erfarenheter av psykisk ohälsa upplever mötet med socialtjänsten, med fokus på bemötande, delaktighet och upplevt stöd. Resultatet visar att intervjupersonernas upplevelser av socialtjänsten var komplexa och varierade, men att vissa gemensamma mönster framträdde. Flera intervjupersoner beskrev mötet med socialtjänsten som en balans mellan stöd och kontroll, där upplevelser av misstro, begränsat inflytande och känslan av att bli kategoriserad som ett ”problem” påverkade kontakten negativt. Samtidigt tyder resultaten på att upplevelsen kunde förändras när en tillitsfull relation etablerades.

Resultaten ligger i linje med tidigare forskning, som betonar betydelsen av bemötande, delaktighet och tillitsfulla relationer i arbetet med unga (Johansen et al., 2024, s. 1, 8). I intervjupersonernas berättelser framstod ett empatiskt och icke-dömande bemötande som betydelsefullt för känslan av trygghet och tillit i kontakten med socialtjänsten. För unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa tycks detta vara särskilt viktigt, då flera intervjupersoner beskrev svårigheter att uttrycka behov, känna sig förstådda och delta aktivt i kontakten med socialtjänsten. Studien ligger även i linje med tidigare forskning om bristande delaktighet och svårigheter att navigera olika stödinsatser (Broad et al., 2017, s. 10). Intervjupersonernas erfarenheter av att beslut fattades utan deras inflytande kan förstås mot bakgrund av socialtjänstens myndighetsutövande roll, där bedömningar och regler ibland begränsade upplevelsen av handlingsutrymme och kontroll. Samtidigt tyder resultaten på att ökad delaktighet och individanpassning kunde bidra till större tillit och känsla av egenmakt över tid.

Resultaten överensstämmer även med tidigare forskning om fragmenterade stödsystem och bristande flexibilitet (Westberg et al., 2020, s. 4, 8-9; Hulin et al., 2024, s. 4). Intervjupersonernas berättelser tyder på att kontakten med flera aktörer och otydliga processer kunde upplevas som särskilt svåra att hantera i kombination med psykisk ohälsa. Studien bidrar samtidigt med en fördjupad förståelse för hur stigma, bemötande och delaktighet samspelar i ungas upplevelser av socialtjänstens myndighetsutövning. I likhet med Sheikhan et al. (2023, s. 8) visar resultaten att upplevelser av att bli dömd, misstolkad eller inte tagen på allvar kunde påverka tilliten och viljan att söka eller ta emot stöd.

Sammanfattningsvis ligger studiens resultat i linje med tidigare forskning, men bidrar med en mer nyanserad förståelse för hur unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa upplevt mötet

med socialtjänsten. Resultaten tyder på att frågor om bemötande, delaktighet och stigma får särskild betydelse för denna grupp, eftersom psykisk ohälsa i vissa fall kan påverka möjligheten att uttrycka behov, känna tillit och navigera socialtjänstens processer. Samtidigt bör resultaten förstås utifrån studiens begränsade urval och intervjupersonernas subjektiva erfarenheter, vilket betyder att resultaten inte kan generaliseras till alla unga vuxna med psykisk ohälsa i kontakt med socialtjänsten. Studien kan dock bidra med ökad förståelse för hur mötet med socialtjänsten upplevs och tolkas av denna grupp.

6.1 Förslag till framtida forskning

Denna studie har bidragit med en fördjupad förståelse för hur unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever mötet med socialtjänsten, men den belyser också flera områden där ytterligare forskning behövs. För det första finns ett behov av studier med större och mer varierade urval för att kunna undersöka hur upplevelser skiljer sig mellan olika grupper av unga vuxna, exempelvis utifrån kön, socioekonomisk bakgrund eller etnicitet. Detta skulle kunna bidra till en mer nyanserad förståelse av hur strukturella faktorer påverkar mötet med socialtjänsten. Vidare skulle longitudinella studier vara värdefulla för att följa unga vuxnas erfarenheter över tid. En sådan ansats skulle kunna ge djupare kunskap om hur relationer, delaktighet och stöd utvecklas samt vilka faktorer som bidrar till långsiktig återhämtning eller avbrott i kontakten.

Det finns även behov av forskning fokuserar på socialsekreterares perspektiv, för att bättre förstå hur organisatoriska ramar, arbetsvillkor och professionella bedömningar påverkar möjligheten att arbeta relationellt och individcentrerat, men även kring hur handlingsutrymmet kan påverka deras beslut. Slutligen skulle framtida studier kunna undersöka konkreta arbetssätt och metoder som främjar empowerment och minskar stigma i praktiken. Genom att identifiera framgångsrika arbetssätt kan sådan forskning bidra till utvecklingen av mer inkluderande och effektiva stödinsatser inom socialtjänsten.

6.2 Kritiskt resonemang om studiens resultat

Resultaten behöver förstås i relation till de olika verksamhetsområden och former av myndighetsutövning som intervjupersonerna har haft kontakt med inom socialtjänsten. Intervjupersonernas erfarenheter omfattar olika typer av stöd och insatser, vilket innebär att

upplevelserna kan ha påverkats av skilda organisatoriska förutsättningar, arbetsmetoder och bedömningar. Upplevelser av begränsad delaktighet och kontroll kan till exempel förstås mot bakgrund av socialtjänstens myndighetsutövande ansvar och de lagar och riktlinjer som styr verksamheten. Detta innebär att negativa erfarenheter inte enbart kan förstås som uttryck för enskilda socialsekreterares bemötande, utan även i relation till de strukturella och organisatoriska ramar som påverkar handlingsutrymmet i praktiken.

Samtidigt tyder resultaten på att relationen till socialsekreteraren, graden av delaktighet och upplevelsen av att bli lyssnad på hade stor betydelse för hur unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa upplevde kontakten med socialtjänsten. En möjlig tolkning är att frågor om tillit, trygghet och individanpassning blir särskilt viktiga för denna grupp, då psykisk ohälsa i vissa fall kan påverka möjligheten att uttrycka behov och navigera kontakten med myndigheter. Resultaten bör också förstås utifrån studiens kvalitativa ansats och urvalets omfattning. Den bör tolkas med försiktighet, eftersom den bygger på ett begränsat antal individers erfarenheter och inte kan representera alla unga vuxnas upplevelser av socialtjänsten. Urvalet har möjliggjort rika och nyanserade beskrivningar av intervjupersonernas erfarenheter, men andra erfarenheter och perspektiv kan samtidigt ha osynliggjort.

Sammanfattningsvis bidrar studien med ökad förståelse för hur unga vuxna med psykisk ohälsa upplever mötet med socialtjänsten, samtidigt som resultaten behöver tolkas till studiens metodologiska begränsningar och den organisatoriska kontext inom vilken olika delar av socialtjänsten verkar.

6.3 Implikationer för socialt arbete

Studiens resultat har flera viktiga implikationer för det praktiska sociala arbetet, särskilt i mötet med unga vuxna med psykisk ohälsa. En central slutsats är att bemötandet har avgörande betydelse för hur stödet upplevs och tas emot. Socialarbetare behöver därför prioritera ett empatiskt, icke-dömande och relationsbaserat arbetssätt, där individen ses som mer än sina problem. Att aktivt lyssna och visa genuint engagemang kan bidra till ökad tillit och därmed bättre förutsättningar för förändringsarbete (Johansen et al., 2024, s. 8; Munford & Sanders, 2015, s. 423). Dessutom visar resultaten att delaktighet är en central faktor för att stärka individens känsla av kontroll och egenmakt (Broad et al., 2017, s. 10). I praktiken innebär detta att socialarbetare bör arbeta mer systematiskt med att involvera unga i beslutsprocesser, tydliggöra valmöjligheter och anpassa insatser efter individuella behov och

mål. Studien lyfter också hur viktigt det är att aktivt arbeta mot stigma (Sheikhan et al., 2023, s. 8). Resultaten i studien indikerar att socialarbetare kan behöva reflektera över sina egna föreställningar och vara medvetna om risken att kategorisera eller förminska individer till en diagnos eller ett problem. Ett holistiskt synsätt, där individens livssituation och erfarenheter tas på allvar, kan bidra till mer träffsäkra och respektfulla insatser.

Slutligen framkommer behovet av ökad flexibilitet och kontinuitet i stödet. Genom att skapa mer samordnade och långsiktiga insatser kan socialtjänsten bättre möta unga vuxnas komplexa behov och bidra till hållbar förändring.

7. Referenslista

Askheim, O.P. (2007). *Empowerment – olika infallsvinklar*. I: Askheim, O.P. & Starrin, B. (red.), *Empowerment i teori och praktik*. Malmö: Gleerups.

Bark, H., Dixon, J. & Laing, J. (2023). The Professional Identity of Social Workers in Mental Health Services: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(11), Artikel 5947. doi:10.3390/ijerph20115947

Beckwith, D., Briggs, L., Shapiro, M. & Carrasco, A. (2021). Engaging young people in early psychosis services - a challenge for social work. *Social Work in Mental Health*, 19(2), s. 105–125. doi:10.1080/15332985.2021.1884636

Broad, K.L., Sandhu, V.K., Sunderji, N. & Charach, A. (2017). Youth experiences of transition from child mental health services to adult mental health services: a qualitative thematic synthesis. *BMC Psychiatry*, 17(1), Artikel 380. doi:10.1186/s12888-017-1538-1

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder*. 3 uppl. Stockholm: Liber.

Falkheimer, J. (2014). Att blanda metoder utan att blanda äpplen och päron. I: Eksell, J. & Thelander, Å. (red.), *Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation*. Lund: Studentlitteratur.

Gebert, F. & Lowe, C. (2025). Social Work Perspectives: Conceptualising Youth Mental Health Through Trauma-Informed Systems Thinking. *Australian Social Work*, 78(4), s. 395–412. doi:10.1080/0312407X.2025.2543406

Goffman, E. (2012). *Stigma: den avvikandes roll och identitet*. Lund: Studentlitteratur.

Hagsgård, A., Lind, C. och Hjorth Warlenius, L. (2025). *Att omhänderta barn och unga: Delbetänkande av Utredningen om stärkt barnrättsperspektiv i LVU* (SOU 2025:38). Regeringskansliet, Stockholm. https://www.regeringen.se/contentassets/c1b6ab4ec2fa4697879c7942ce64c916/sou-2025-38.pdf

Hulin, J., Huddy, V., Oliver, P., Marshall, J., Mohindra, A., Delaney, B. & Mitchell, C. (2024). Experiences of support for people who access voluntary, community and social enterprise (VCSE) organisations for self-harm: a qualitative study with stakeholder feedback. *BMC Public Health*, 24(1), s. 1059–10, Article 1059. doi:10.1186/s12889-024-18455-4

Jämställdhetsmyndigheten (2020). *Psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna*. https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/linjrawb/bilaga-3-psykisk-ohalsa-hos-ungdomar-och-unga-vuxna-2.pdf

Johansen, M., Stuen, H. K., Brekke, E., Jensen, C. B. & Landheim, A. (2024). A qualitative study of the experiences of young people with severe mental health problems and complex needs regarding youth flexible assertive community treatment. *Frontiers in Psychiatry*, 15, s. 1478345. doi:10.3389/fpsyt.2024.1478345

Kunskapsguiden (2024). *Om psykisk hälsa och ohälsa*. https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/psykisk-ohalsa/psykisk-halsa-och-ohalsa/omp sykisk-halsa-och-ohalsa/

Munford, R. & Sanders, J. (2015). Components of Effective Social Work Practice in Mental Health for Young People who are Users of Multiple Services. *Social Work in Mental Health*, 13(5), s. 415–438. doi:10.1080/15332985.2014.959239

Nord-Baade, S., Ness, O., Rowe, M., Jensen, C. B. & Landheim, A. (2026). Social inclusion among young adults with mental illness and complex needs in Flexible Assertive Community Treatment: A qualitative study on team staff's understanding and experiences. *PLOS ONE,* 21(1), e0341358. doi:10.1371/journal.pone.0341358

Sheikhan, N. Y., Henderson, J. L., Halsall, T., Daley, M., Brownell, S., Shah, J., Iyer, S. N. & Hawke, L. D. (2023). Stigma as a barrier to early intervention among youth seeking mental health services in Ontario, Canada: a qualitative study. *BMC Health Services Research*, 23(1), s. 86, Article 86. doi:10.1186/s12913-023-09075-6

Socialstyrelsen (2024). *Förekomst av psykisk ohälsa bland barn och unga.* https://www.socialstyrelsen.se/contentassets/fb2afeba14d24131a7cc95b219ba3aa5/2024-5-9083.pdf

Westberg, K. H., Nygren, J. M., Nyholm, M., Carlsson, I.-M. & Svedberg, P. (2020). Lost in space - an exploration of help-seeking among young people with mental health problems: a constructivist grounded theory study. *Archives of Public Health*, 78(1), s. 93, Article 93. doi:10.1186/s13690-020-00471-6

Åkerström, M. (2014). Olika vetenskapsteoretiska perspektiv ger olika kunskap: Leave the gun – take the cannoli. I: Eksell, J. & Thelander, Å. (red.), *Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation*. Lund: Studentlitteratur.

8. Bilagor

8.1 Bilaga 1 - intervjuguide

INTERVJUGUIDE

Unga vuxnas upplevelser av mötet med socialtjänsten vid psykisk ohälsa

Inledande information innan intervjun börjar:

Informera intervjupersonen om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att intervjun spelas in om hen samtycker, att hen kan avbryta när som helst samt att materialet anonymiseras.

Innan intervjun startar:

Är det okej att vi spelar in intervjun?

Bakgrundsfrågor

(Syftet med bakgrundsfrågorna är att skapa trygghet och kontext)

Kan du berätta lite om dig själv? (t.ex. ålder och vad du gör idag)

Hur kom det sig att du fick kontakt med socialtjänsten?

Följdfrågor:

Var det du själv som tog kontakt eller någon annan?

Hur gammal var du ungefär när kontakten började?

Hur länge hade du kontakt med socialtjänsten?

Vilken typ av stöd handlade kontakten främst om?

Tema 1 – Bemötande och upplevelser av att bli sedd

(Koppling till stigma och bemötande)

Hur upplevde du ditt första möte med socialtjänsten?

Följdfrågor:

Hur blev du bemött av socialsekreteraren?

Hur kände du dig under mötet?

Hur skulle du beskriva bemötandet från socialtjänsten generellt under tiden du hade kontakt med dem?

Kan du berätta om ett tillfälle då du kände dig särskilt bra bemött?
Vad var det som gjorde att det kändes bra?
Hur påverkade det din upplevelse av kontakten?
Har du varit med om något möte där du kände dig missförstådd eller dåligt bemött?
Vad var det som gjorde att det kändes så?
Hur påverkade det din syn på socialtjänsten?
Upplevde du att du blev bemött som en individ eller utifrån din psykiska ohälsa?
Kände du att socialtjänsten hade förutfattade meningar om dig?
Har du någon gång känt dig dömd eller annorlunda i kontakten med socialtjänsten?

Tema 2 – Delaktighet, inflytande och kontroll
(Koppling till empowerment – self-determination och agency)

Hur upplevde du möjligheten att vara delaktig i beslut som rörde ditt stöd?

Följdfrågor:
Fick du möjlighet att uttrycka dina egna behov?
Upplevde du att dina åsikter togs på allvar?
På vilket sätt fick du vara med och påverka de beslut som togs?
Kände du att du faktiskt kunde påverka besluten, eller upplevde du att de redan var bestämda?
Har du varit med om situationer där beslut togs utan att du kände dig delaktig?
Hur upplevde du det?
Hur påverkade det din känsla av kontroll över situationen?
Hur skulle du beskriva balansen mellan dina egna önskemål och socialtjänstens beslut?

Fördjupning (empowerment):
Kände du att du förstod hur besluten fattades och varför?
Upplevde du att stödet stärkte din självständighet eller gjorde dig mer beroende?

Tema 3 – Upplevelse av stöd i relation till behov
(Koppling till empowerment och livsvillkor)

Vilket stöd fick du från socialtjänsten?

Följdfrågor:
Hur fungerade stödet i praktiken?

Hur länge fick du stödet?
Hur upplevde du att stödet passade dina behov?
På vilket sätt hjälpte stödet dig i din situation?
Var det något stöd du hade önskat men inte fick?
Kände du att stödet utgick från dina egna mål och behov, eller från socialtjänstens bedömningar?

Tema 4 – Självbild, öppenhet och hantering av situationen
(Koppling till stigma – identitet och informationskontroll)

Påverkade kontakten med socialtjänsten hur du såg på dig själv?
Kände du att du kunde vara öppen om din situation med socialtjänsten?
Var det något du valde att inte berätta? Varför?
Upplevde du att du behövde anpassa hur du uttryckte dig eller betedde dig i mötet med socialtjänsten?

Tema 5 – Hinder och möjligheter i mötet med socialtjänsten
(Koppling till både empowerment och strukturella faktorer)

Vad tycker du fungerade bra i din kontakt med socialtjänsten?
Vad upplevde du som svårt eller problematiskt i kontakten?

Följdfrågor:
Var det något i systemet eller organisationen som gjorde det svårt?
Var det något i bemötandet som påverkade din upplevelse?

Följdfrågor om struktur:
Upplevde du att regler eller rutiner begränsade dina möjligheter att få det stöd du behövde?
Kände du att systemet var anpassat efter dina behov?
Vad tycker du hade kunnat göra kontakten med socialtjänsten bättre?
Vad tycker du är viktigt för att unga med psykisk ohälsa ska känna sig hjälpta av socialtjänsten?

Avslutande frågor

Om du tänker tillbaka på din kontakt med socialtjänsten, hur skulle du sammanfatta din upplevelse?
Vilka råd skulle du vilja ge till socialtjänsten när de möter unga vuxna med psykisk ohälsa?
Är det något mer du skulle vilja berätta som vi inte har frågat om?

Tacka intervjupersonen för deltagandet och avsluta intervjun.

8.2 Informations- och samtyckesblankett

Informations- och samtyckesblankett förstudentarbeten vid Södertörns högskola

Information till deltagare

Du har blivit tillfrågad att delta i studien "Lyssnar de verkligen? - Unga vuxnas upplevelser av mötet med socialtjänsten vid psykisk ohälsa". Enligt dataskyddsförordningen (2016/679) är Södertörns högskola personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingar i studentarbeten. I det här dokumentet får du information om hur dina personuppgifter kommer att behandlas inom ramen för denna studie.

Personuppgifter som kommer att behandlas

För att uppnå syftet med studien kommer följande personuppgifter om dig att samlas in och behandlas:

- Namn
- E-postadress
- Intervjusvar

Utöver de personuppgifter som framgår ovan kommer även så kallade känsliga personuppgifter att samlas in och behandlas. Nedan framgår vilka känsliga personuppgifter som kommer att samlas in och behandlas inom ramen för denna studie:

- Uppgifter om din psykiska ohälsa
- Uppgifter om din kontakt med socialtjänsten

Syftet med studien och personuppgiftsbehandlingen

Studien utförs som en del i min utbildning, inom Socionomprogrammet vid institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola. Syftet med studien är att undersöka hur unga vuxna som har lidit av psykisk ohälsa upplever mötet med socialtjänsten, med särskilt fokus på bemötande, delaktighet och upplevt stöd. Studien avser att belysa hur dessa upplevelser formas i samband med socialtjänstens handläggningsprocesser och insatser.

Deltagandet i studien innebär att du deltar i en enskild intervju där du får berätta om dina erfarenheter av kontakt med socialtjänsten. Intervjun kommer att ha formen av ett samtal utifrån ett antal teman, såsom bemötande, delaktighet och upplevt stöd.

Intervjun genomförs vid ett tillfälle och beräknas ta cirka 45–60 minuter. Den kommer att ske digitalt via videolänk.

Samtalet kommer att spelas in för att kunna analyseras i efterhand, men allt material behandlas konfidentiellt och anonymiseras. Det innebär att inga uppgifter som kan identifiera dig kommer att finnas med i studien. Vill du inte bli inspelad kommer dina svar att skrivas ner i pappersform eller i ett Google-dokument.

Det är nödvändigt att behandla dina känsliga personuppgifter för att kunna uppnå syftet med studien.

Handledarens lämplighetsbedömning av känsliga personuppgifter

Inför denna studie har min handledare gjort en så kallad lämplighetsbedömning av behandling av känsliga personuppgifter. Syftet med lämplighetsbedömningen är bland annat att säkerställa att aktuellt studentarbete genomförs under etiskt godtagbara former.

Handledaren Linda Kridahl har den (ange datum för när handledaren godkände lämplighetsbedömningen) godkänt att känsliga personuppgifter behandlas inom ramen för denna studie.

Med stöd av vilken rättslig grund kommer personuppgifterna att behandlas?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt informerade samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak. Ett återkallande påverkar dock inte den behandling som skett innan återkallandet.

Hur personuppgifterna kommer att förvaras och skyddas under arbetets gång

Dina personuppgifter kommer att förvaras digitalt på en lösenordsskyddad lagringsyta (OneDrive) som endast jag har tillgång till. Inspelat material och transkriberingar kommer att behandlas konfidentiellt och lagras på ett säkert sätt.

Allt material kommer att avidentifieras, vilket innebär att namn och andra uppgifter som kan kopplas till dig tas bort eller ersätts med kod. Det innebär att du inte kommer att kunna identifieras i den färdiga studien.

Personuppgifterna kommer endast att användas för denna studie och kommer inte att delas med obehöriga. Efter att studien är avslutad och godkänd kommer allt inspelat material och personuppgifter att raderas.

Hur länge personuppgifterna kommer att behandlas

Dina personuppgifter kommer att behandlas till dess studentarbetet är avslutat och betygsatt med godkänt betyg. Därefter kommer personuppgifterna att raderas. Ditt namn eller något annat som direkt skulle kunna identifiera dig kommer inte att finnas med i resultatet.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Södertörns högskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien (registerutdrag), och vid behov få eventuella felaktiga personuppgifter rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Vill du utnyttja någon av dessa rättigheter eller återkalla ditt samtycke ska du kontakta ansvarig student eller studentens handledare (kontaktuppgifter finns nedan):

Klagomål

Om du har några funderingar eller klagomål avseende hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta högskolans dataskyddsombud via dataskydd@sh.se. Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du inte är nöjd med högskolans personuppgiftsbehandling. IMY nås via e-post: imy@imy.se eller telefon 08-657 61 00.

Ansvariga för studien

Huvudansvarig för studien är:
Linda Kridahl, Institutionen för samhällsvetenskaper
E-post: [redacted]@sh.se

Studien genomförs av:
(Valentina Alwan, Lilia Hatem)
Studenter vid Socionomprogrammet, Södertörns högskola
E-post: [redacted]@hotmail.com, [redacted]@gmail.com

Samtycke till att delta i studien "Lyssnar de verkligen? - Unga vuxnas upplevelser av mötet med socialtjänsten vid psykisk ohälsa

Jag har tagit del av informationen om studien och samtycker till att delta i studien "Lyssnar de verkligen? - Unga vuxnas upplevelser av mötet med socialtjänsten vid psykisk ohälsa. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta deltagandet i studien utan att ange skäl för det. Genom min underskrift väljer jag att delta i studien och godkänner att Södertörns högskola behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.

Datum och ort

_____

Underskrift

_____

Namnförtydligande

_____

8.3 Kodschema

8.3 Kodschema - Tematisk analys

Tema 1: Bemötande i mötet med socialtjänsten

Citat	Initial kod	Undertema	Tema
“Jag kände mig typ… som ett problem. Inte som en person.” (Y)	Objektifiering	Att inte bli sedd som individ	Bemötande
“Det var mer som ett ärende” (C)	Objektifiering	Avpersonifiering	Bemötande
“Ja… absolut. Ung kille som blivit skjuten, droger, avhoppad skola… de tänker ju sitt direkt.” (Y)	Förutfattade meningar	Stigmatiserande bedömning	Bemötande
“man känner det… i blickar… i hur de pratar” (B)	Indirekt dömande	Icke-verbalt stigma	Bemötande
“Jag kände mig också… väldigt liten. Som att mitt liv bara… bestämdes över mitt huvud” (B)	Maktlöshet	Underordning	Bemötande
“Han var väldigt strikt… typ ‘du måste sluta’… det funkade inte på mig” (Y)	Auktoritärt bemötande	Icke-fungerande kontroll	Bemötande
“Hon bara… okej, berätta vad som hände” (Y)	Icke-dömande bemötande	Öppenhet	Bemötande

“Hon var ganska lugn… inte dömande” (E)	Empatiskt bemötande	Trygghet	Bemötande
“Och jag trodde de skulle skälla ut mig… men hon frågade vad som hände innan” (E)	Förväntad kritik vs stöd	Förståelse	Bemötande
“Hon stannade upp… sa ‘det här är inte okej’” (C)	Bekräftelse	Emotionell respons	Bemötande
“Jag vågade vara mer ärlig” (M)	Trygghet	Tillit	Bemötande
“Jag satt där… tänkte ‘snälla låt det gå över’” (S)	Skam	Osäkerhet	Bemötande
“Hon pressade mig inte… det gjorde att jag kände mig inte attackerad” (S)	Icke-pressande bemötande	Trygg kommunikation	Bemötande
“Det var första gången någon brydde sig om varför” (S)	Erkännande	Validitet	Bemötande

Tema 2: Delaktighet och inflytande

Citat	Initial kod	Undertema	Tema
“Det var mer som att de sa ‘det här är planen’” (Y)	Top-down beslut	Låg delaktighet	Delaktighet
“Typ noll” (B)	Total frånvaro	Exkludering	Delaktighet

“Jag kände att jag inte hade kontroll över någonting” (Y)	Maktlöshet	Förlorad kontroll	Delaktighet
“Mitt liv var inte mitt” (S)	Frånkoppling	Kontrollförlust	Delaktighet
“Vi satte typ mål tillsammans” (M)	Samarbete	Aktiv delaktighet	Delaktighet
“Jag fick tillbaka lite kontroll” (M)	Återvunnen kontroll	Empowerment	Delaktighet
“Jag kände inget inflytande i början” (E)	Begränsat inflytande	Initial exkludering	Delaktighet
“Det bara hände… jag blev hemlös igen” (C)	Påtvingade beslut	Strukturell makt	Delaktighet
“Jag började rymma från familjehemmet” (B)	Motstånd	Reaktion	Delaktighet
“Jag var beredd på utskällning men hon frågade bara” (S)	Förväntningsbrott	Delaktighet i dialog	Delaktighet

Tema 3: Stöd i relation till behov

Citat	Initial kod	Undertema	Tema
“Behandlingshemmet… det var det som hjälpte” (Y)	Effektivt stöd	Anpassat stöd	Stöd

“Jag började känna igen mig själv igen” (Y)	Återhämtning	Identitetsstöd	Stöd
“Små steg som blev stora” (M)	Progressivt stöd	Praktiskt stöd	Stöd
“Jag började se mig själv som någon som kunde förändras” (M)	Självförändring	Empowerment	Stöd
“Det kändes som standardlösningar” (S)	Standardisering	Brist på individanpassning	Stöd
“Jag behövde trygghet men fick osäkerhet” (C)	Felanpassning	Bristande behov	Stöd
“Familjehemmet funkade inte alls” (B)	Misslyckad insats	Ineffektivt stöd	Stöd
“Det hjälpte inte med familjesamtal” (S)	Ineffektiv insats	Bristande träffsäkerhet	Stöd
“När man kommer ut… då är det svårt” (Y)	Brist på uppföljning	Avsaknad av kontinuitet	Stöd

Tema 4: Stigma och självbild

Citat	Initial kod	Undertema	Tema
“Då var jag bara ‘missbrukare’” (Y)	Kategorisering	Stigmatisering	Stigma

“Hon med problem” (B)	Etikettering	Social kategorisering	Stigma
“Jag började känna mig som ett problem” (C)	Internaliserat stigma	Negativ självbild	Stigma
“Jag kände mig ännu mer trasig” (B)	Självstigma	Självbild	Stigma
“Jag skämdes mycket” (Y/B)	Skam	Emotionell belastning	Stigma
“Jag sa det jag trodde de ville höra” (B)	Strategisk anpassning	Informationskontroll	Stigma
“Typ invandrartjej… då blir man en viss typ” (S)	Stereotypisering	Social kategorisering	Stigma
“Jag såg mig själv som en förlorare” (Y)	Negativ identitet	Självbild	Stigma
“Mina suicidtankar kom fram” (Y)	Psykisk påverkan	Allvarlig självbild	Stigma
“Jag började öppna mig mer… annars blir man en golare” (E)	Social anpassning	Strategisk identitet	Stigma

Tema 5: Strukturella hinder och möjligheter

Citat	Initial kod	Undertema	Tema

“Systemet hängde inte ihop” (Y)	Fragmentering	Bristande samordning	Struktur
“Man fick ringa hit och dit” (Y)	Navigationsbörda	Systemkomplexitet	Struktur
“Reglerna kändes fyrkantiga” (C)	Regelstyrning	Stel struktur	Struktur
“Det kändes stelt” (M)	Byråkratisk rigiditet	Brist på flexibilitet	Struktur
“När man fick rätt person…” (S/Y)	Personberoende stöd	Relationell kvalitet	Struktur
“De kunde inte göra det som behövdes” (B)	Begränsat mandat	Institutionella hinder	Struktur
“Soc, vård, frivård… allt var separat” (Y)	Systemsplittring	Strukturell fragmentering	Struktur
“Systemet var segt” (S)	Långsam process	Ineffektivitet	Struktur
“Jag fick ta mycket ansvar själv” (Y)	Överförd börda	Systemansvar på individ	Struktur
“Det var avgörande när någon faktiskt lyssnade” (B)	Relationsberoende	Kvalitativ variation	Struktur